



การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา การขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์นิชา เรืองชัยทวีสุข

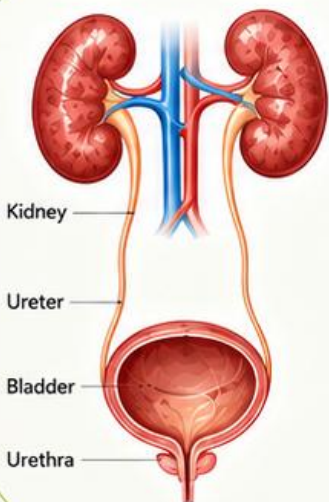
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



URINARY ELIMINATION

การขับถ่ายปัสสาวะ

- ✓ การประเมินการขับถ่ายปัสสาวะ
- ✓ ความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ
- ✓ การสวนปัสสาวะ
- ✓ การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ
- ✓ ภาวะแทรกซ้อนและการป้องกัน



Safe & Quality Nursing Care

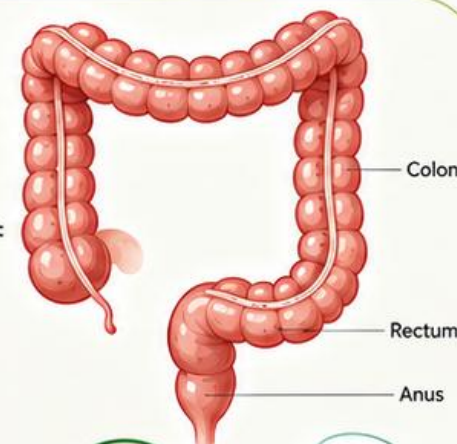
ส่งเสริมการขับถ่ายอย่างเหมาะสม
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วย



BOWEL ELIMINATION

การขับถ่ายอุจจาระ

- ✓ การประเมินการขับถ่ายอุจจาระ
- ✓ ภาวะท้องผูก
- ✓ ภาวะอุจจาระอัดแน่น
- ✓ การสวนอุจจาระ
- ✓ การดูแลทวารเทียม
- ✓ ภาวะแทรกซ้อนและการป้องกัน



NURSING CARE

การพยาบาล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์



ASSESSMENT

ประเมินอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมและต่อเนื่อง



PREVENTION

ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
และส่งเสริมสุขภาพ



INTERVENTION

ให้การพยาบาลที่เหมาะสม
ตรงตามปัญหา



PATIENT SAFETY

ปลอดภัย ใส่ใจ
ได้มาตรฐาน



วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : นิสิตสามารถ

- 1 อธิบายการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะได้
- 2 อธิบายการประเมินการทำหน้าที่และบอกอาการและการแสดงที่ผิดปกติของผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะได้
- 3 อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะได้
- 4 บอกวิธีการสวนปัสสาวะ การคาสายสวนปัสสาวะ การถอดสายสวนปัสสาวะ วิธีการใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ การเก็บปัสสาวะส่งตรวจได้
- 5 บอกภาวะแทรกซ้อนจากการคาสายสวนปัสสาวะ
- 6 อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะได้
- 7 บอกความผิดปกติในการขับถ่ายอุจจาระได้
- 8 อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติในการขับถ่ายอุจจาระ
- 9 บอกวิธีการสวนอุจจาระได้



BIO



GREEN



HEALTH



NURSING CARE



PATIENT SAFETY

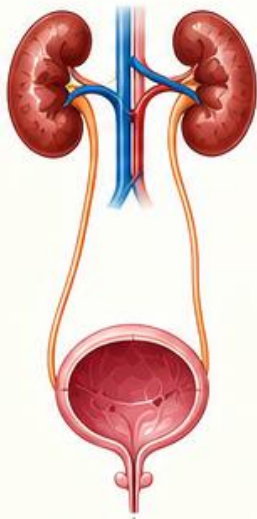
“ ใส่ใจ ดูแล ด้วยหัวใจ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ”

เนื้อหา

ประกอบด้วย

1

การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา การขับถ่ายปัสสาวะ



1.1 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของระบบทางเดินปัสสาวะ



1.2 การประเมินการขับถ่ายปัสสาวะ
อาการและอาการแสดงที่ผิดปกติ
ของผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ



1.3 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการ
สวนปัสสาวะ



การสวนปัสสาวะ



การคาสายสวน
ปัสสาวะ



การถอดสายสวน
ปัสสาวะ



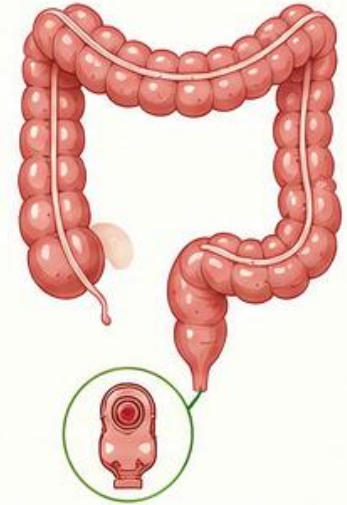
การใส่ถุงยางอนามัย
เพื่อระบายปัสสาวะ



การเก็บปัสสาวะ
ส่งตรวจ

2

การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา การขับถ่ายอุจจาระ



2.1 กระบวนการ
ขับถ่ายอุจจาระ



2.2 ความผิดปกติในการ
ขับถ่ายอุจจาระ



2.3 การสวนอุจจาระผู้ป่วย

ความผิดปกติที่พบบ่อย



ท้องผูก
(Constipation)



ท้องเสีย
(Diarrhea)



อุจจาระอัดแน่น
(Fecal impaction)



ลำไส้อุดตัน
(Intestinal obstruction)



ทวารเทียม
(Ostomy)

1.1

กายวิภาคและสรีรวิทยา ของระบบทางเดินปัสสาวะ

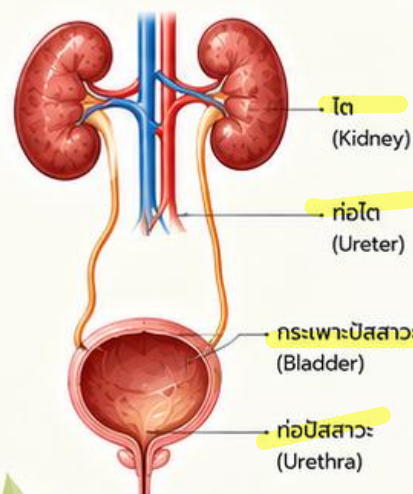
1. การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัญญฉิชา เรืองชัยทวิสุข

การขับถ่ายปัสสาวะเป็นกลไกสำคัญในการกำจัดของเสียและรักษาสมดุลของร่างกาย เมื่อระบบทางเดินปัสสาวะเกิดความผิดปกติ อาจส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย

ปัสสาวะจากไต → Bladder → Bladder พัง ส่ง signal ไป
ไขสันหลัง กระเบนเหน็บโดย pelvic nerve → ส่งต่อไป
pons ที่มี PMC → กระปรดแค้นคือตัวกระเพาะปัสสาวะ
→ ถ้าจะปล่อย PMC จะส่ง signal มา Cerebrum

กายวิภาคของระบบทางเดินปัสสาวะ



หน้าที่สำคัญ

- ✓ กำจัดของเสียออกจากร่างกาย
- ✓ รักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่
- ✓ รักษาสมดุลกรด-ด่าง
- ✓ ควบคุมความดันโลหิต

กระบวนการขับถ่ายปัสสาวะ แบ่งเป็น 2 ช่วง

1 ช่วงเก็บกักปัสสาวะ (Storage Phase)



2 ช่วงขับถ่ายปัสสาวะ (Voiding Phase)

เมื่อพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม PMC จะส่งสัญญาณควบคุมการทำงาน

ระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก (Sympathetic)

ออกจากไขสันหลังระดับคอคู่ที่ 11 - บั้นเอวคู่ที่ 2 ผ่านเส้นประสาท pelvic → ทำให้

- หูรูดกักปัสสาวะส่วนใน (Internal urethral sphincter) คลายตัว

ระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic)

ออกจากไขสันหลังระดับกระเบนเหน็บคู่ที่ 2-4 ผ่านเส้นประสาท pelvic → ส่งสัญญาณไปยังกระเพาะปัสสาวะ

- กระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัว

ระบบประสาทโซมาติก (Somatic Nervous System)

ออกจากไขสันหลังระดับกระเบนเหน็บคู่ที่ 2-4 ผ่านเส้นประสาท pudendal

- ทำให้กล้ามเนื้อหูรูดกักปัสสาวะส่วนนอก (External urethral sphincter) และกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic floor muscles)
- หดตัวในช่วงเก็บกักปัสสาวะ
- คลายตัวในช่วงขับถ่ายปัสสาวะ

สรุปการทำงาน

เก็บกักปัสสาวะ (Storage Phase)

- กระเพาะปัสสาวะคลายตัว
- หูรูดกักปัสสาวะส่วนในหดตัว
- หูรูดกักปัสสาวะส่วนนอกหดตัว

ขับถ่ายปัสสาวะ (Voiding Phase)

- กระเพาะปัสสาวะบีบตัว
- หูรูดกักปัสสาวะส่วนในคลายตัว
- หูรูดกักปัสสาวะส่วนนอกคลายตัว

เป้าหมายการพยาบาล

- ✓ ส่งเสริมการขับถ่ายปัสสาวะอย่างปกติ
- ✓ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
- ✓ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

บทบาทพยาบาล



ประเมินอาการ
อย่างเป็นระบบ



ให้ความรู้และคำแนะนำ



ป้องกันภาวะแทรกซ้อน



ส่งเสริมการฟื้นฟู
สมรรถภาพ



ดูแลด้วยความเอาใจใส่
และปลอดภัย

BIO • GREEN • HEALTH

นวัตกรรมเกษตรสุขภาพ สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

1.2 การประเมินการขับถ่ายปัสสาวะ อาการและอาการแสดงที่ผิดปกติของผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ

การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์นิชา เรืองชัยทวิสุข



1.2.1 การประเมินแบบแผนการขับถ่ายปัสสาวะ

แบบแผนการขับถ่ายปัสสาวะของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป การประเมินเพื่อทราบภาวะปกติของผู้ป่วย เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลและเฝ้าระวังความผิดปกติ



ความถี่ในการถ่ายปัสสาวะ

4-6 ครั้ง/วัน
กลางคืน 0-1 ครั้ง



ปริมาณปัสสาวะ
ที่ขับถ่ายใน 1 วัน

1,200-1,500
มิลลิลิตร



ปริมาณปัสสาวะ
แต่ละครั้ง

250-400
มิลลิลิตร



ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ
และลักษณะปัสสาวะ

- ปริมาณน้ำที่ได้รับ
- การขับน้ำออกทางอื่น ๆ
- การทำหน้าที่ของไต



ลักษณะปกติ

ปัสสาวะไหลพุ่งออกเป็นสาย
ไม่มีการปวดขณะถ่ายปัสสาวะ

1.2.2 ลักษณะและส่วนประกอบของปัสสาวะ และลักษณะของปัสสาวะที่ผิดปกติ

ส่วนประกอบของปัสสาวะปกติ



น้ำ
95%



ยูเรีย
2%



เกลือแร่
1.5%



สารอื่น ๆ
1.5%
(กรดยูริก, เครอะตินีน,
แอมโมเนีย, ออร์โธอิน)

ลักษณะของปัสสาวะ

ลักษณะ	ปกติ	ผิดปกติ (อาจบ่งบอกถึงภาวะ)
สี	เหลืองอ่อน - เหลืองเข้ม	- ใส/ไม่มีสี (ดื่มน้ำมากเกินไป) - เหลืองเข้ม/น้ำตาล (ขาดน้ำ, ตึข่าน) - แดง/ชมพู (เลือดปน, บิว, ติดเชื้อ) - น้ำนมขุ่น (ติดเชื้อ, มีเม็ดเลือดขาว) - ดำ/น้ำตาลเข้ม (ภาวะตับ, ยาบางชนิด)
ความใส	ใส	ขุ่น ปัสสาวะติดเชื้อ, มีเม็ดเลือดขาว, เซลล์เยื่อ)
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ฉุน/เหม็นผิดปกติ (ติดเชื้อ, สารบางอย่างในอาหาร/ยา)
ความถี่ จำเพาะ	1.005 - 1.030	ต่ำกว่าปกติ (ไตทำงานลดลง) สูงกว่าปกติ (ขาดน้ำ, เบาหวาน)
pH	4.5 - 8.0	นอกช่วงปกติ (ติดเชื้อ, โรคไต, ยาบางชนิด)

กรดนิตริก

1.2.3 อาการและอาการแสดงที่ผิดปกติของผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ

อาการเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะ



ปัสสาวะบ่อย
(ตอนกลางวัน
หรือกลางคืน)



ปัสสาวะลำบาก
หรือถ่ายลำบาก



ปัสสาวะกะปริบ
หรือไหลไม่สุด



ปัสสาวะหยุด
เป็นช่วง ๆ



ปัสสาวะเลือด
กลืนไม่ได้

อาการเกี่ยวกับลักษณะปัสสาวะ



ปัสสาวะขุ่น
มีกลิ่นเหม็น



ปัสสาวะมีเลือดปน
(สีชมพู แดง น้ำตาล)



ปัสสาวะมีฟอง
มากผิดปกติ



ปริมาณปัสสาวะ
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ



ปวดหรือแสบร้อน
ขณะถ่ายปัสสาวะ

อาการอื่น ๆ ที่อาจพบร่วม



ปวดท้องน้อย
หรือปวดเอว



มีไข้หนาวสั่น



คลื่นไส้
อาเจียน



อ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร



บวม
ความดันโลหิตสูง



การประเมินอย่างละเอียดและต่อเนื่อง
ช่วยให้พบความผิดปกติได้เร็ว ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
และวางแผนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

1.2 การประเมินการขับถ่ายปัสสาวะ อาการและอาการแสดงที่ผิดปกติของผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ

1.2.2 ลักษณะและส่วนประกอบของปัสสาวะและลักษณะของปัสสาวะที่ผิดปกติ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์นิชา เรืองชัยทวิสุข



ลักษณะและส่วนประกอบของปัสสาวะ

การประเมิน	ลักษณะและรายละเอียด
สี	ปัสสาวะปกติมีสีเหลืองอ่อน สีปัสสาวะจะสัมพันธ์กับจำนวนน้ำที่ร่างกายได้รับ ถ้าได้รับน้ำจำนวนมากปัสสาวะจะมีสีเหลืองอ่อนใสหรือไม่มีสี หากได้รับน้ำน้อยหรือมีการขับน้ำออกจากร่างกายทางอื่นมาก เช่น เหงื่อออกมาก ท้องเสีย ปัสสาวะจะมีสีเหลืองเข้ม อาหาร ยา และสารสีต่างๆ มีผลให้สีปัสสาวะเปลี่ยนไป
ความใส	ปกติปัสสาวะมีความใส ไม่มีตะกอน แต่หากทิ้งไว้นานส่วนประกอบที่เจือปนจะตกตะกอนขุ่นได้ นอกจากนี้อาจมีแบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ปัสสาวะขุ่นได้
กลิ่น	ปัสสาวะจะมีกลิ่นฉุนอ่อน ๆ หากทิ้งไว้นานจะมีกลิ่นของแอมโมเนีย
ส่วนประกอบ	ปัสสาวะประกอบด้วยน้ำร้อยละ 90-95 ที่เหลือประกอบด้วยของเสีย สารอินทรีย์ และเกลือแร่ที่ขับออกมาจากไต ได้แก่ สารไนโตรเจน ยูเรีย ครีเอตินีน กรดยูริก โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม แอมโมเนีย และสิ่งเจือปนเล็กน้อย ได้แก่ เซลล์เยื่อบุผิว และผลึกของเกลือ
ความตึงจำเพาะ 1.003 - 1.030	ค่าปกติอยู่ระหว่าง 1.003-1.030 เป็นการวัดความสามารถของไตในการควบคุมความเข้มข้น และส่วนประกอบของของเหลวในร่างกายให้คงที่ ค่าความตึงจำเพาะสูงแสดงว่าปัสสาวะเข้มข้น อาจเกิดจากการดื่มน้ำน้อยหรือเสียน้ำมาก ค่าความตึงจำเพาะต่ำแสดงว่าปัสสาวะเจือจาง อาจเกิดจากการดื่มน้ำมากหรือเป็นโรคที่ทำให้ปัสสาวะออกมากผิดปกติ เช่น โรคเบาจัด
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.5-6.0	น้ำปัสสาวะมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ pH ประมาณ 4.5 - 6 ค่าความเป็นกรดต่างของปัสสาวะเปลี่ยนแปลงตามการเผาผลาญอาหาร ชนิดของอาหาร โรค และยา อาหารประเภทเนื้อทำให้ปัสสาวะมีฤทธิ์เป็นกรด ผัก ผลไม้ทำให้ปัสสาวะมีฤทธิ์เป็นด่าง

ปริมาณปัสสาวะปกติ



ผู้ใหญ่ถ่าย
4-6 ครั้ง/วัน



กลางคืน 0-1 ครั้ง
(โดยการทำงานลง
ประมาณ 1/3 ของกลางวัน)



ปริมาณปัสสาวะต่อวัน
1,200 - 1,500 มิลลิลิตร



ปัสสาวะแต่ละครั้ง
ประมาณ 250 - 400 มิลลิลิตร
ไหลพุ่งออกเป็นสาย
ไม่มีการปวดขณะถ่าย

ลักษณะของปัสสาวะที่ผิดปกติ

มีเลือดในปัสสาวะ (Hematuria)	เป็นภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงปนในปัสสาวะ อาจเห็นด้วยตาเปล่า หากมีจำนวนเลือดปนมากเป็นสีเนื้อหรือมีเส้นเลือดปน บางครั้งอาจสังเกตเห็นเพียงปัสสาวะมีสีชมพู ซึ่งตรวจพบเม็ดเลือดแดงจากการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การมีเลือดปนในปัสสาวะแสดงถึงการมีพยาธิสภาพที่ไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะ
มีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ (Pyuria)	เป็นภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะและอาจพบแบคทีเรียร่วมด้วย ปัสสาวะจะมีลักษณะขุ่น มีตะกอน ตรวจพบเม็ดเลือดขาวจากการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การมีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะแสดงถึงการอักเสบติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ
มีโปรตีนในปัสสาวะ (Proteinuria หรือ albuminuria)	เป็นการตรวจพบอัลบูมิน (Albumin) ในปัสสาวะ แสดงถึงภาวะที่ไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะมีการอักเสบ หรือพบในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันเลือดสูง หรือการสัมผัสสารโลหะหนักบางชนิด เช่น พรอก แคลเมียม มีฤทธิ์ในการทำลายเนื้อไต และอาจพบเป็นครั้งคราวในผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนัก
มีน้ำตาลในปัสสาวะ (Glycosuria)	เป็นการตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ แสดงถึงการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ จนถูกขับออกทางไต ซึ่งพบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มีคีโตนในปัสสาวะ (Ketonuria)	เป็นการตรวจพบคีโตนหรืออะซิโตน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของคีโตนในปัสสาวะ คีโตนเกิดจากการเผาผลาญไขมันเพื่อให้ได้พลังงานแทนพลังงานที่ได้จากกลูโคส พบในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ขาดอินซูลิน (Insulin) ทำให้เซลล์ไม่สามารถนำกลูโคสไปสลายเป็นพลังงาน หรือผู้ที่ขาดอาหารอย่างรุนแรง
มีเซลล์เยื่อบุทางเดินปัสสาวะ (Epithelial cells)	เป็นภาวะที่ตรวจพบเซลล์เยื่อบุในปัสสาวะ แสดงถึงการอักเสบหรือมีพยาธิสภาพของทางเดินปัสสาวะ
มีผลึก (Crystal)	เป็นการตรวจพบผลึกของเกลือออกซาเลตหรือฟอสเฟตในปัสสาวะ แสดงถึงการมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
ปัสสาวะมีสีเหลืองน้ำตาลของบิลิรูบิน (Bilirubinuria)	เป็นภาวะที่มีเม็ดเลือดน้ำดีในปัสสาวะทำให้มีสีน้ำตาลเข้ม สาเหตุจากการอุดตันของท่อน้ำดีจากต้นสู่ลำไส้เล็ก ทำให้น้ำดีไหลย้อนกลับไปที่ตับและถูกเปลี่ยนเป็นเกล็ดที่ละลายน้ำได้ ขับออกทางปัสสาวะ



BIO



GREEN



HEALTH



NURSING CARE



"ใส่ใจ ดูแล ด้วยหัวใจ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย"

อ้างอิง: วรรณภา ประไพพาณิชย์. (2566). การพยาบาลผู้สูงอายุ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

1.2 การประเมินการขับถ่ายปัสสาวะ อาการและอาการแสดงที่ผิดปกติของผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ

1.2.3 อาการและอาการแสดงที่ผิดปกติของผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์นิษา เรืองชัยทวิสุข



อาการ	อาการแสดงที่ผิดปกติ
 ปัสสาวะลำบาก (Dysuria)	มีลักษณะถ่ายไม่ออก ถ่ายขัด ถ่ายไม่สุด น้ำปัสสาวะไหลช้า ต้องออกแรงเบ่งเพิ่มขึ้น และอาจมีอาการเจ็บปวดมากขณะถ่าย อาจเกิดเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ท่อปัสสาวะตีบตันจากการบาดเจ็บ หรือต่อมลูกหมากโตในเพศชาย ผู้ป่วยมักจะบอกเล่าอาการว่า “ต้องออกแรงเบ่งตอนเริ่มถ่ายหรือตอนใกล้ถ่ายสุด” “ถ่ายปัสสาวะไม่พุ่ง ออกเป็นสายเล็ก” “ปัสสาวะขาดตอน ถ่ายได้แต่เดี๋ยวก็หยุด”
 ถ่ายปัสสาวะบ่อยครั้ง หรือถ่ายปัสสาวะ กระปริดกระปรอย (Pollakiuria)	เป็นการถ่ายปัสสาวะบ่อยครั้งกว่าปกติ แต่ละครั้งจำนวนปัสสาวะออกน้อย อาจเกิดจากกระเพาะปัสสาวะมีความจุลดลงจากก้อนเนื้อออก นิ้ว หรือกระเพาะปัสสาวะมีการหดตัวตลอดเวลาจากการอักเสบติดเชื้อ การตีบตันบริเวณคอกระเพาะปัสสาวะต่อกับท่อปัสสาวะ หรือมีปัญหาจากการอุดกั้นที่ท่อปัสสาวะบางส่วน เช่น ภาวะต่อมลูกหมากโต
 ถ่ายปัสสาวะไม่ออก (Urinary retention)	เป็นภาวะที่มีปัสสาวะจำนวนมากค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแต่ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะออกได้ อาจเกิดเนื่องจากการตีบตันบริเวณคอกระเพาะปัสสาวะที่ต่อกับท่อปัสสาวะหรือตีบตันที่ท่อปัสสาวะ เช่น ภาวะต่อมลูกหมากโต หรือมีการกระเพาะปัสสาวะทึงจากการผ่าตัดอวัยวะบริเวณใกล้เคียง หรือการได้รับยาาระงับความรู้สึก เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หลังคลอด
 กลั้นปัสสาวะไม่ได้ (Urinary incontinence)	เป็นภาวะที่ปัสสาวะเล็ดไหลออกมาหรือกลั้นไม่ได้ก่อนถึงช่องน้ำที่ต้องการ มีอาการแสดงได้หลายลักษณะและจากสาเหตุต่างกัน ดังนี้ กลั้นปัสสาวะไม่ได้เลย (True incontinence) เป็นภาวะที่มีการไหลของปัสสาวะตลอดเวลาทั้งขณะหลับและตื่น โดยไม่มีความรู้สึกปวดอยากถ่ายปัสสาวะ อาจเกิดเนื่องจากมีรูรั่วของทางเดินปัสสาวะ และอาจพบได้ในผู้ป่วยที่เพิ่งเอาสายสวนปัสสาวะออกหลังจากใส่สายสวนเป็นเวลานาน ในระยะแรกผู้ป่วยจะกลั้นปัสสาวะไม่ได้เพราะกลัมน้ำปัสสาวะที่ไหลออกมาในตรงคอของกระเพาะปัสสาวะและกลัมน้ำปัสสาวะที่ไหลออกมาตรงท่อปัสสาวะส่วนต้นเสียหน้าที่ในการหดตัวกลั้นปัสสาวะ กลั้นปัสสาวะไม่อยู่นิ่งรีบด่วน (Urgency incontinence) เป็นภาวะที่มีปัสสาวะไหลออกมากันทันทีที่รู้สึกปวดถ่ายปัสสาวะ เกิดจากกลัมน้ำปัสสาวะที่กระเพาะปัสสาวะและรูรั่วทำงานผิดปกติไม่สามารถกลั้นการไหลของปัสสาวะได้ กลั้นปัสสาวะไม่อยู่นิ่งมีปัสสาวะเล็ด (Stress incontinence) เป็นภาวะที่มีปัสสาวะเล็ดออกมาเมื่อมีการกระทำที่ทำให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น เช่น ไอ จาม หัวเราะ เบ่ง การเปลี่ยนท่าหรือยกของหนัก เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดชั้นในและชั้นนอกลดลง การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นิ่งนี้พบบ่อยมากในผู้สูงอายุสตรีที่มีบุตรมากเนื่องจากกล้ามเนื้อภายในอุ้งเชิงกรานหย่อนยาน

จำนวนปัสสาวะผิดปกติ

- 
1 ไม่มีปัสสาวะ (Anuria)
 เป็นภาวะที่ไม่มีปัสสาวะหรือปัสสาวะออกน้อยกว่า 100 มิลลิลิตรต่อวัน และผู้ป่วยไม่มีอาการปวดอยากถ่ายปัสสาวะ พบในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่อง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะช็อกมีระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว
- 
2 ปัสสาวะน้อย (Oliguria)
 เป็นภาวะที่มีปัสสาวะออกน้อยกว่า 500 มิลลิลิตรต่อวัน สาเหตุจากการทำงานของไตบกพร่อง ภาวะขาดน้ำ
- 
3 ปัสสาวะบ่อยและมีจำนวนมากผิดปกติ (Polyuria)
 เป็นภาวะที่มีปริมาณปัสสาวะมากกว่าปกติ ปัสสาวะจะมากกว่า 2,500 มิลลิลิตรต่อวัน พบในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ผู้ป่วยได้รับยาขับปัสสาวะ ผู้ป่วยโรคเบาจืด
- 
4 ปัสสาวะเวลากลางคืน (Nocturia)
 เป็นภาวะที่ปัสสาวะมากกว่า 3 ครั้งในเวลากลางคืน พบในผู้ที่ดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ก่อนนอน ผู้ที่ได้รับยาขับปัสสาวะ ผู้ที่มีต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยเบาหวาน
- 
5 ปัสสาวะค้าง (Residual urine)
 เป็นภาวะที่มีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะภายหลังการถ่ายปัสสาวะมากกว่า 50 มิลลิลิตร สาเหตุจากความบกพร่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ



“ ใส่ใจ ดูแล ด้วยหัวใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ”

1.3 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนปัสสาวะ

1.3.1 การสวนปัสสาวะ

การสวนปัสสาวะ (Urinary Catheterization) คือ การสอดใส่สายสวนที่ปราศจากเชื้อผ่านทางท่อปัสสาวะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ เพื่อระบายปัสสาวะให้ไหลออกสู่ภายนอก มี 2 วิธี ดังนี้

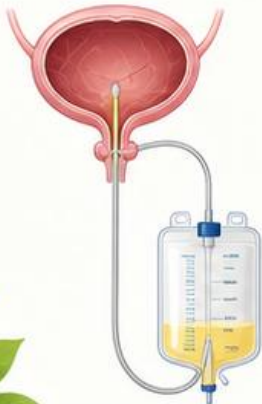


ชนิดของการสวนปัสสาวะ



1 การสวนปัสสาวะทิ้งเป็นครั้ง ๆ (Intermittent catheterization)

เป็นการสอดใส่สายสวนที่ปราศจากเชื้อผ่านทางท่อปัสสาวะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อระบายปัสสาวะให้ไหลออกสู่ภายนอก และถอดสายสวนออกเมื่อปัสสาวะไหลออกหมด



2 การสวนคาสายปัสสาวะ (Retention of urethral catheter)

เป็นการสอดใส่สายสวนที่ปราศจากเชื้อผ่านทางท่อปัสสาวะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อระบายปัสสาวะให้ไหลออกสู่ภายนอกและคาสายสวนไว้เพื่อให้ปัสสาวะไหลออกได้ตลอดเวลา

ข้อบ่งชี้



1 ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะเองไม่ได้เนื่องจากบริเวณไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ



2 ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะเองไม่ได้ภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากปัสสาวะครั้งสุดท้ายเนื่องจากท่อปัสสาวะได้รับบาดเจ็บหรือกระแทกกระเทือน เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยหลังคลอดบุตร หรือจากฤทธิ์ยาาระงับความรู้สึก เป็นต้น



3 ต้องการให้กระเพาะปัสสาวะว่างในกรณีที่ต้องทำผ่าตัดหรือเตรียมตรวจ



4 วัดปริมาณของปัสสาวะค้าง (Residual urine)



1 ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะเองไม่ได้เนื่องจากมีการอุดตันของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง เช่น ต่อมลูกหมากโต ท่อปัสสาวะตีบ



2 ผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องได้รับการประเมินจำนวนปัสสาวะต่อชั่วโมงเพื่อประเมินการทำหน้าที่ของไต เช่น ผู้ป่วยช็อก



3 ผู้ป่วยที่มีปัสสาวะค้างจำนวนมากกว่า 50 มิลลิลิตร แม้ได้รับการสวนปัสสาวะทิ้ง (Intermittent) มากกว่า 2 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้น และไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการอื่นๆ



4 ผู้ป่วยที่ต้องจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณสะโพก เช่น ผู้ป่วยที่กระดูกเชิงกรานหัก



5 ผู้ป่วยเตรียมผ่าตัดใหญ่ที่จะได้รับปริมาณสารน้ำจำนวนมากหรือขับปัสสาวะระหว่างผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ใช้เวลานานและได้รับยาาระงับความรู้สึก



6 ผู้ป่วยหญิงที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ เพื่อส่งเสริมการหายของแผลเปิดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์หรือกันบก



7 ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในกระเพาะปัสสาวะต้องได้รับการสวนล้าง (Irrigation)



8 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อส่งเสริมความสบายของผู้ป่วย



BIO



GREEN



HEALTH



NURSING CARE



PATIENT SAFETY

“ใส่ใจ ดูแล ด้วยหัวใจ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย”



1 สายสวนปัสสาวะ (Urinary catheter) มี 2 แบบ ดังนี้

กรณีสวนทิ้ง (Intermittent catheterization)



ใช้สายสวนปัสสาวะชนิดตรง
ทำจากยางแดง ปลายข้างที่ใส่ใน
กระเพาะปัสสาวะมีลักษณะเป็น
ท่อกลวงปลายมน มีรูเปิดตาเดียว
ใช้สำหรับสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราว

กรณีสวนคาปัสสาวะ (Retention of urethral catheter)



ใช้สายสวนปัสสาวะโฟลีย์
(Foley's catheter) มีชนิด 2 หาง
กับ 3 หาง (ชนิด 2 หางใช้สำหรับ
สวนคาปัสสาวะ ส่วนชนิด 3 หาง
ใช้สำหรับสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ)

*ขนาดที่ใช้



เด็ก

ใช้ขนาด
6-8 เฟรนช์



ผู้หญิง

ใช้ขนาด
14-16 เฟรนช์



ผู้ชาย

ใช้ขนาด
16-20 เฟรนช์

2 ชุดสวนปัสสาวะ (Urinary catheterization set) 1 ชุดประกอบด้วย

ชามรูปไต
1 ใบ



ถ้วยใส่สำลี
4-5 ถ้วย และ
ผ้าก๊อซ 3x3 นิ้ว



ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยว
(Non tooth forceps)



ใช้หยิบจับสำลีทำความสะอาด
อวัยวะสืบพันธุ์ก่อนการ
สวนปัสสาวะ (บางแห่งใช้
ถุงมือปราศจากเชื้อแทน)

ผ้าสี่เหลี่ยม
เจาะกลาง 1 ผืน



ใช้คลุมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
ทั้งหน้าท้องและโคนขา

3 ชามรูปไต
หรือ ถ้วย
สำหรับใส่สำลี
ที่ใช้แล้ว



4 ถุงมือปราศจากเชื้อ
2 คู่



5 น้ำยาทำความสะอาด
หรือน้ำยาทำลายเชื้อ
(Antiseptic solution)

เพื่อใช้ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์
ภายนอกก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ เช่น
แชฟลอน 1 : 100
บางสถานพยาบาลใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อ
หรือน้ำสบู

6 สารหล่อลื่นชนิดที่
ละลายในน้ำได้
เช่น เค-วายเจลลี่
(K-Y jelly)



กรณีคาสายสวนปัสสาวะ มีอุปกรณ์เพิ่มเติมดังนี้

7 ถุงใส่ปัสสาวะ
(Urine bag)



8 กระบอกฉีดยา
ปราศจากเชื้อ
(Sterile syringe)
ขนาด 10 ซีซี



9 พลาสเตอร์
สำหรับติด
สายสวนปัสสาวะ



10 ผ้าปิดตา



BIO



GREEN



HEALTH

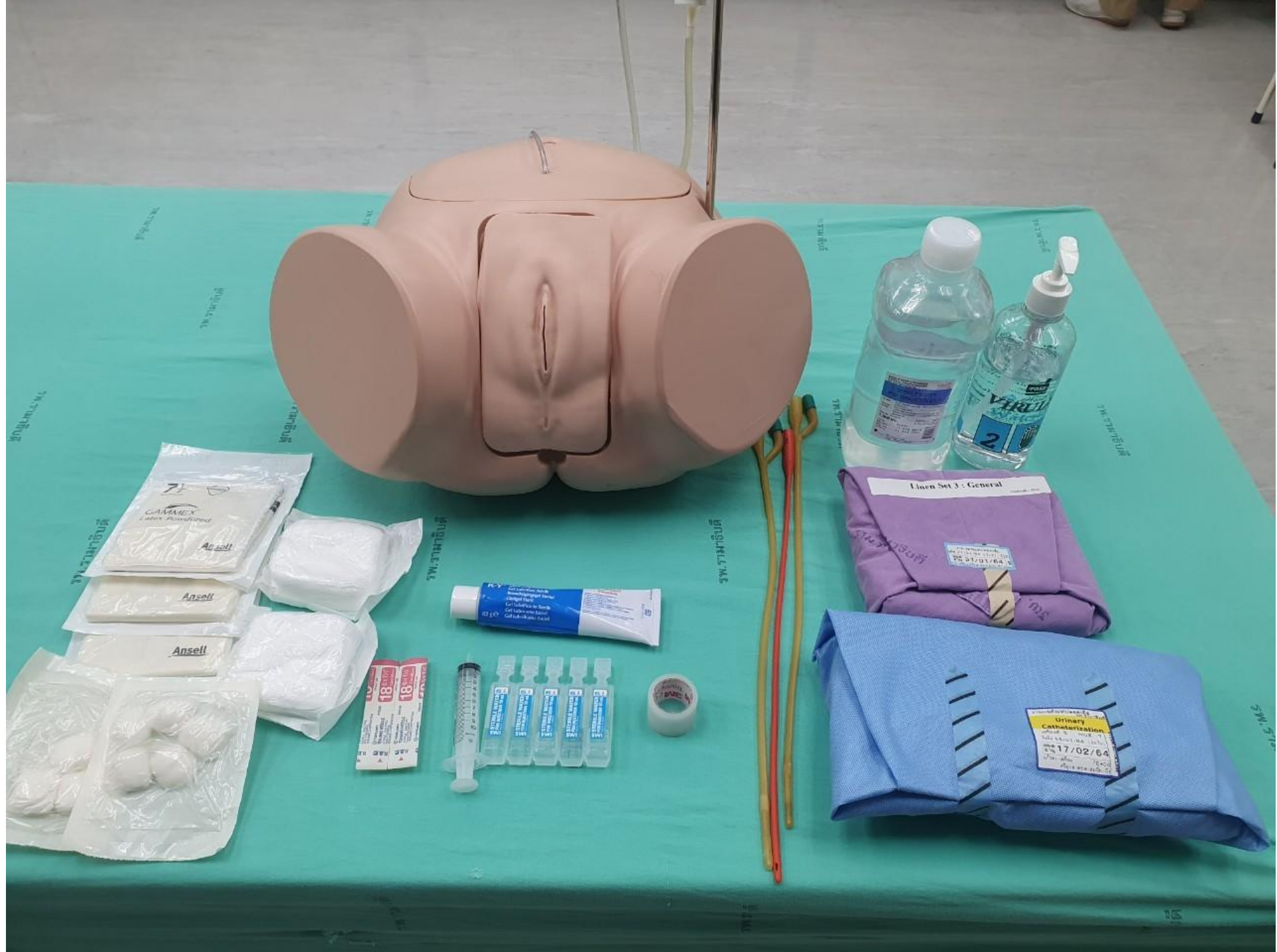


NURSING CARE



PATIENT SAFETY

“ใส่ใจ ดูแล ด้วยหัวใจ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย”



TYPES OF URINARY CATHETER



FOLEY CATHETER

Indwelling

Balloon Retention



THREE-WAY CATHETER

Continuous Irrigation

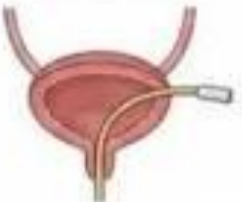
Postoperative Use



NELATON CATHETER

No Balloon

Intermittent Drainage



SUPRAPUBIC CATHETER

Abdominal Entry

Long-Term Access



1.3.1 การสวนปัสสาวะทั้งเป็นครั้ง ๆ

การสวนปัสสาวะผู้ป่วยหญิง ปฏิบัติดังนี้



การประเมิน (assessment)

- 1 ตรวจสอบแผนการรักษาของแพทย์ ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เพศ ห่อง หรือเตียง และวัตถุประสงค์ของการใส่สายสวนปัสสาวะ
- 2 ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย สอบถามชื่อ นามสกุลผู้ป่วย
- 3 ประเมินสภาพผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม เช่น ระดับความสามารถ ในการช่วยเหลือตนเอง และการให้ความร่วมมือ ความสะอาด บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ แสงสว่าง หากไม่เพียงพอควรจัดเตรียม ไฟฉายหรือโคมไฟส่องสว่างไปด้วย

เหตุผล

- 1 เพื่อวางแผนให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
- 2 เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยตามแผนการรักษา
- 3 เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และจัดหาผู้ช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่ให้ความร่วมมือ



การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ตัวอย่างเช่น

- 1 มีความพร้อมในการขับถ่ายปัสสาวะเนื่องจากผู้ป่วยไม่รู้สีกักตัว
- 2 เสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเนื่องจากการใส่สายสวนปัสสาวะ
- 3 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนปัสสาวะ



การวางแผน (planning) ภายหลังจากการสวนปัสสาวะ

- 1 ผู้ป่วยมีการระบายปัสสาวะออกได้สะดวก ไม่เกิดการคั่งค้างของปัสสาวะ
- 2 ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
- 3 ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนปัสสาวะ
- 4 ผู้ป่วยมีความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อสวนคาสายสวนปัสสาวะ



เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพภายหลังการพยาบาล ในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนปัสสาวะ โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่อผู้ป่วย





การสวนปัสสาวะผู้ป่วยหญิง

ขั้นตอนการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกก่อนการสวนปัสสาวะ



ใช้สาลีชุบน้ำยาทำความสะอาด บีบหมาด ๆ และเช็ดตามลำดับ

ใช้สาลีก้อนใหม่ทุกครั้ง และเช็ดในทิศทางเดียว (จากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวา) เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค



1 ก่อนที่ 1

เช็ดบริเวณหัวเหน่าด้านซ้าย
ไปขวาเป็นทางเดียวกัน
ไปทางหน้าท้อง



2 ก่อนที่ 2

เช็ดแคมนอกด้านใกล้ตัว
จากด้านบนลงด้านล่าง



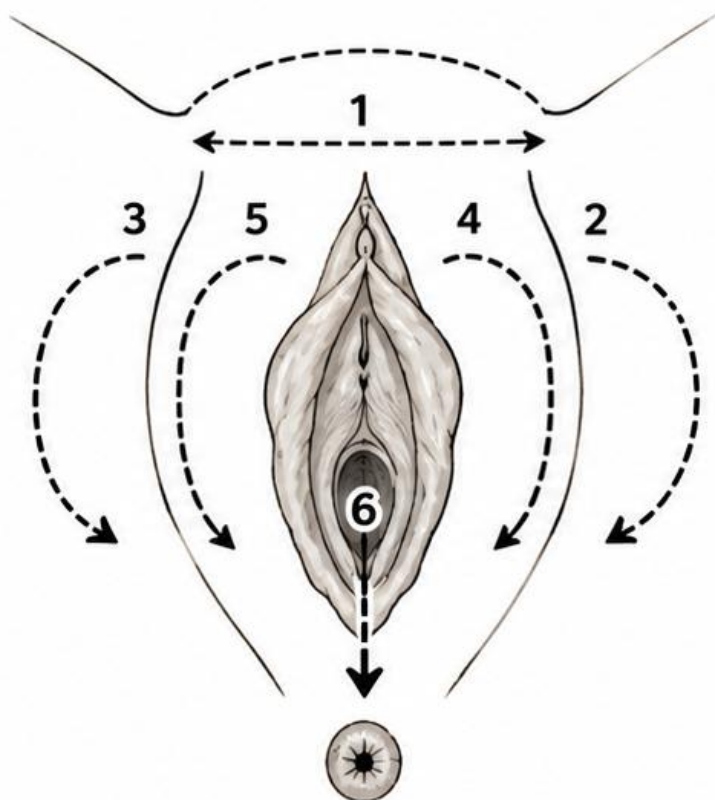
3 ก่อนที่ 3

เช็ดแคมนอกด้านไกลตัว
จากด้านบนลงด้านล่าง



! ข้อควรระวัง

- ใช้สาลีก้อนใหม่ทุกครั้ง
- เช็ดในทิศทางเดียว เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค
- ทั้งสาลีที่ใช้แล้วในขามรูปไต



4 ก่อนที่ 4

ใช้มือข้างที่ไม่ถนัด
แยก labia ไว้ จนกว่าจะเช็ด
ถึงสาลีก้อนสุดท้าย เช็ดแคมใน
ด้านใกล้ตัวจากด้านบน
ลงด้านล่าง



5 ก่อนที่ 5

เช็ดแคมในด้านใกล้ตัว
จากด้านบนลงด้านล่าง



6 ก่อนที่ 6

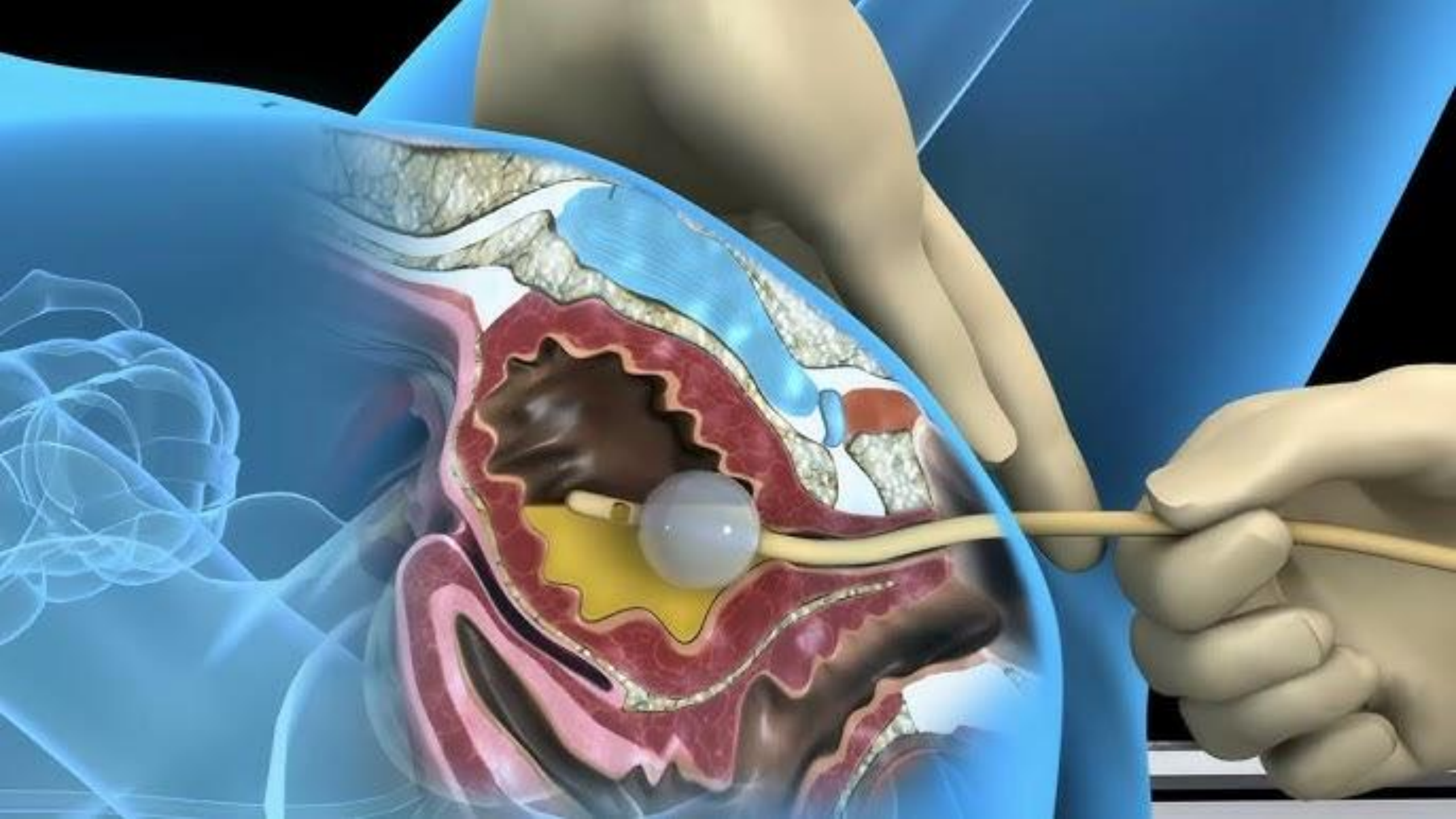
เช็ดตรงกลาง โดยเช็ด
จากด้านบนลงด้านล่าง
จนถึงทวารหนัก



เหตุผล

เพื่อทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และท่อทางเดินปัสสาวะ
ให้สะอาดที่สุด ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

ขั้นตอนการสวน ดูจากการสาธิตของอาจารย์





การสวนปัสสาวะผู้ป่วยชาย ปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติการพยาบาล (IMPLEMENTATION)

ขั้นตอนการประเมิน (assessment) การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)
การวางแผน (planning) การประเมินผล (evaluation)
การบันทึกและรายงาน (documentation)
ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ป่วยหญิง

ขั้นตอนการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก (ข้อ 11)

ใช้สำลีชุบน้ำยาทำความสะอาด เช็ดตามลำดับ

1 ก่อนที่ 1

ใช้มือข้างที่ไม่ถนัด จับส่วนองคชาตยื่น
รูปหนึ่งหุ้มปลาย (Prepuce of penis) ลง
เพื่อให้เห็นรูเปิดท่อปัสสาวะ เช็ดบริเวณ
รูเปิดท่อปัสสาวะ โดยเช็ดเป็นวงกลม
จากในออกนอก **ไม่ย้อนกลับ**
(เช่น ห้านเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์
ด้วยน้ำสบู่แล้วเช็ดตามด้วย
น้ำสะอาด แล้วจึงรดหนึ่งหุ้มปลาย
ขึ้นตามเดิม

2 ก่อนที่ 2

เช็ดบริเวณองคชาต วนจากปลาย
ลงมาถึงโคนโดยรอบ

3 ก่อนที่ 3

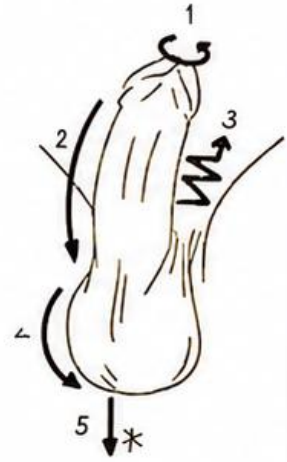
เช็ดบริเวณหัวหน่าวไปยังหน้าท้อง

4 ก่อนที่ 4

เช็ดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาด

5 ก่อนที่ 5

เช็ดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งทางหน้า



*** แต่ละบริเวณสามารถใช้น้ำสะอาดได้มากกว่า 1 ก่อน หากเห็นว่าไม่สะอาดพอ
สำหรับภายหลังที่ใช้แล้วให้ทิ้งที่อ่างรูปใด ในกรณีที่ใช้สำลีชุบน้ำยาชำระใช้น้ำสะอาด
เช็ดซ้ำตามวิธีเดียวกัน



อุปกรณ์ที่ใช้



หมายเหตุสำคัญ

- ใช้สำลีใหม่ทุกครั้ง และเช็ดในทิศทางเดียว (ไม่ย้อนกลับ)
- ทิ้งสำลีที่ใช้แล้วในถังขยะ
- หากใช้น้ำสบู่น้ำยา: ให้ใช้น้ำสะอาดเช็ดซ้ำตามวิธีเดียวกัน

วิธีปฏิบัติ

เหตุผล

	7 จัดท่านอนหงาย เปิดผ้าคลุม โดยเปิดเผยเฉพาะส่วนที่จำเป็น	เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกเย็นสบายและพักฟื้นง่ายขึ้น
	8 วางชุดสวนปัสสาวะและถุงรองรับขยะไว้ปลายเตียงผู้ป่วย หรืออาจวางชุดสวนปัสสาวะไว้บนโต๊ะข้างเตียง หรือถาดเบี่ยงของความสะดวกสบาย	เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ
	9 เปิดชุดสวนปัสสาวะ โดยใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ เทน้ำยาทำความสะอาดบนสำลี	เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค
	10 สวมถุงมือปราศจากเชื้อ (sterile) คู่แรก	เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค
	11 หยิบสำลีชุบน้ำยาสำหรับทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ และบริเวณท่อน้ำปัสสาวะ เช็ดทำความสะอาดบริเวณรูเปิดของท่อน้ำปัสสาวะ (ตามขั้นตอนข้อที่ 1-5)	เพื่อทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ และบริเวณท่อน้ำปัสสาวะ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคมากที่สุด
	12 เก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วออกห่างจากบริเวณใกล้ตัวผู้ป่วย ถอดถุงมือออก	เพื่อให้อุปกรณ์สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป
	13 บีบสารหล่อลื่นลงบนผ้าที่วางในชุดสวน ปัสสาวะของสายสวนปัสสาวะ ปล่อยสายสวน ปัสสาวะลงในชุดสวน และเปลี่ยนถุงมือคู่อีกคู่หนึ่ง	เพื่อให้ขั้นตอนการสวนดำเนินไปอย่างสะดวก และปราศจากเชื้อโรค
	14 คลี่ผ้าสีก่อนจะกางออก และวางคลุมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์จนถึงหน้าขา ระมัดระวังไม่ให้ถุงมือสัมผัสกับบริเวณที่ไม่ปลอดภัย	เพื่อให้สะอาดปราศจากเชื้อ
	15 เช็ดองคชาต/ตัวรองรับน้ำปัสสาวะบนผ้าสีก่อนจะกาง	เพื่อเป็นอุปกรณ์รองรับน้ำปัสสาวะ
	16 กางสายสวนจากส่วนปลายของสายสวนลงตามความยาวของท่อน้ำปัสสาวะ หลังสิ้นประมาณ 6-7 นิ้ว	เพื่อให้สายสวนได้งอ ลดความตึงเครียดและระคายเคือง ซึ่งจะทำให้เกิดความเจ็บปวดขณะใส่สาย
	17 วางปลายสายสวนด้านเปิด ในถาด/ถ้วยสำหรับรองรับน้ำปัสสาวะ	เพื่อให้น้ำปัสสาวะไหลลงไปในถาด/ถ้วยสำหรับรองรับน้ำปัสสาวะ
	18 ใช้สำลีชุบน้ำยาตามนโยบายของโรงพยาบาลเช็ดบริเวณรูเปิดของท่อปัสสาวะ	เพื่อให้มีของแห้งบริเวณรูเปิดของท่อปัสสาวะ
	19 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับองคชาตยื่นขึ้น 90 องศา ในรายที่หนึ่งหุ้มปลายไม่เปิด ใช้มือชี้และนิ้วหัวแม่มือหนีงหนึ่งหุ้มปลายลง	เพื่อกำหนดรูเปิดของท่อน้ำปัสสาวะที่สะอาด

วิธีปฏิบัติ

เหตุผล

	20 ค่อย ๆ สอดปลายหัวสายสวนเข้าทางรูเปิดของท่อน้ำปัสสาวะ อย่างนุ่มนวล ขณะใส่สายสวน ควรพูดคุยกับผู้ป่วยถึงความรู้สึก เช่น ความรู้สึกเจ็บปวด หรืออยากถ่ายปัสสาวะ	เพื่อให้ใส่สายสวนได้ง่าย ลดความกระตือรือร้น ต่อเนื้อเยื่อ และป้องกันการฉีกขาดของท่อน้ำปัสสาวะ
	21 หากมีการติดขัดหรือหัวสายสวนปัสสาวะ ให้ใช้วิธีค่อย ๆ หมุนสายสวนปัสสาวะเข้าไป ไม่ให้ดึงสายเข้าไป หรือเบ้น้ำใส่ผู้ป่วย หายใจเข้าออกลึก ๆ รอสักครู่ เพื่อให้กล้ามเนื้อหูรูดคลายตัว แล้วจึงใส่ใหม่	เพื่อลดความกระตือรือร้นต่อเนื้อเยื่อ และป้องกันการฉีกขาดของท่อน้ำปัสสาวะ
	22 ถ้าผู้ป่วยมีความเจ็บปวดมาก และใส่ไม่ได้ ให้หยุดใส่ และรายงานให้พยาบาลหัวหน้าเวรทราบ	เพื่อพิจารณาพยาบาลแพทย์ต่อไป
	23 เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะสำเร็จประมาณ 6-8 นิ้ว จะมีน้ำปัสสาวะ ไหลออกมา ให้ดึงปลายสายสวนเข้าไปอีกเล็กน้อย	เพื่อให้ปลายสายสวนอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ
	24 เมื่อใส่สายสวนได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว เช็ดมือข้างที่จับ องคชาตกับสายสวนค้างไว้ สังเกตว่าลักษณะของปัสสาวะที่ออกมา ว่ามีลักษณะใส ปุ่น เหลือง หรือก้อนปนออกมาหรือไม่	การจับสายสวนปัสสาวะไว้เพื่อป้องกันสายสวน ปัสสาวะที่หลุด การสังเกตลักษณะของ น้ำปัสสาวะที่ไหลออกมาเพื่อตรวจหาความผิดปกติ หรือไม่อย่างไร
	25 หากมีปัสสาวะออกมาเต็มด้วยรอง พับสายไว้สักครู่ เพื่อกำน้ำปัสสาวะ ใส่ลงในขวดรอง หลังจากนั้นก็ทิ้งรองใหม่ รองจนกว่าน้ำปัสสาวะจะหยุดไหล	เพื่อประเมินจำนวนน้ำปัสสาวะที่ออกมา
	26 ถ้าต้องการเก็บตัวอย่างน้ำปัสสาวะส่งตรวจ ควรปล่อยให้ปัสสาวะ ไหลออกสักครู่หนึ่งก่อน แล้วจึงใช้กรวยดูดปัสสาวะ จำนวนตัวอย่างที่ประมาณ 15-20 มิลลิลิตร	เพื่อให้ได้ตัวอย่างช่วงกลางการไหล ของน้ำปัสสาวะ
	27 เมื่อปัสสาวะหยุดไหลแล้ว ลองกดบริเวณท้องน้อยเบา ๆ หากปัสสาวะออกมาหมดแล้ว ค่อย ๆ ดึงสายสวนออกจากท่อน้ำปัสสาวะ ปัสสาวะ โดยการพับปลายสายสวนก่อนดึงออก	เพื่อตรวจสอบว่ายังมีปัสสาวะค้างอยู่หรือไม่ และป้องกันการไหลย้อนของน้ำปัสสาวะกลับ เข้าในกระเพาะปัสสาวะ
	28 ถอดถุงมือออก	เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
	29 เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากบริเวณใกล้ตัวผู้ป่วย จัดผ้าปูและเตียงให้เรียบร้อย	เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
	30 เปิดผ้าปิดตา ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสม	เพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
	31 จัดให้ผู้ป่วยพักผ่อนในท่าที่สบาย	เพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน
	32 นำอุปกรณ์ไปทำความสะอาด และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย	เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อย



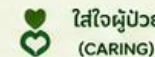
สะอาด
(CLEAN)



ปลอดภัย
(SAFE)



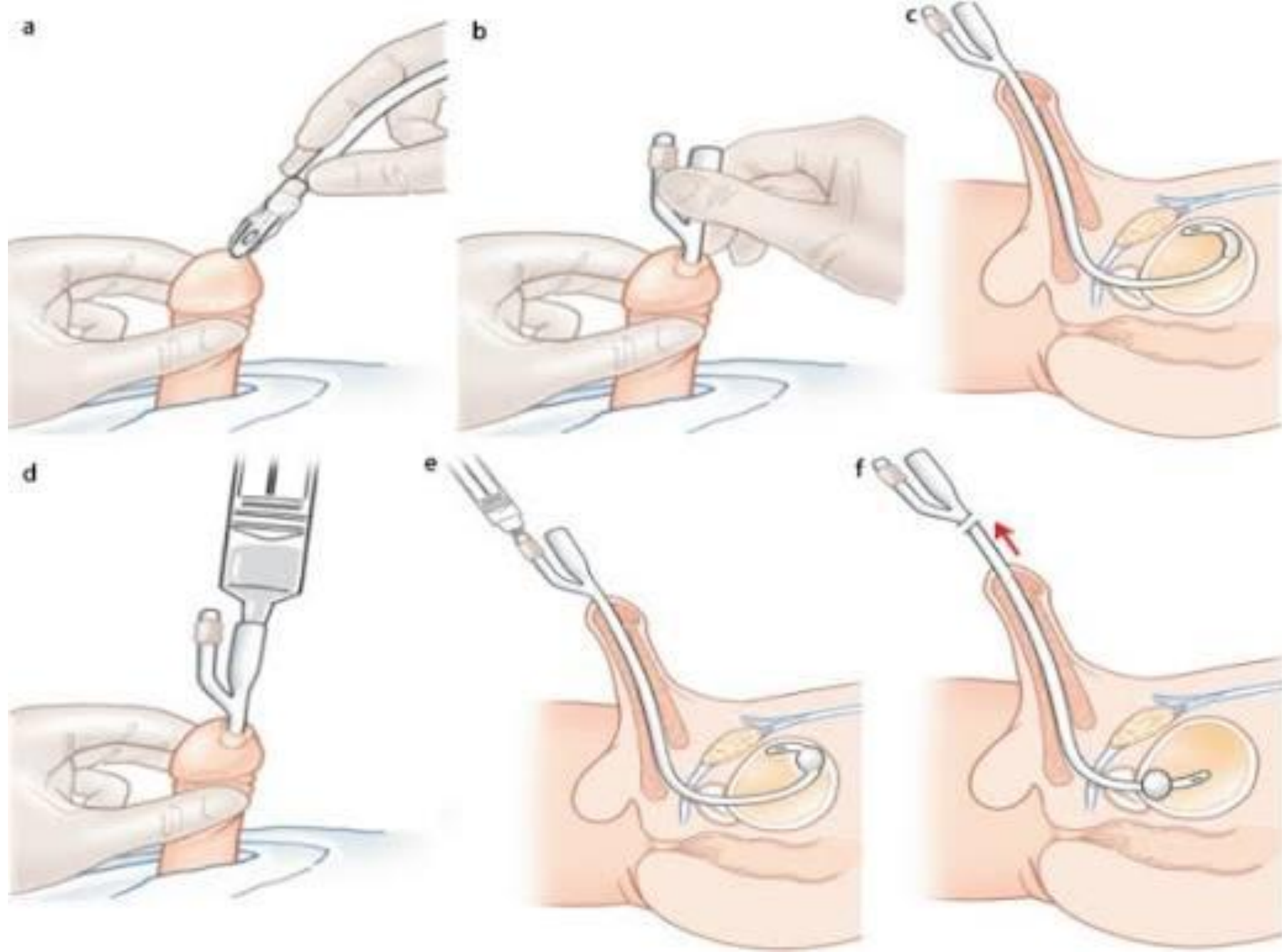
เคารพสิทธิ์
(RESPECT)

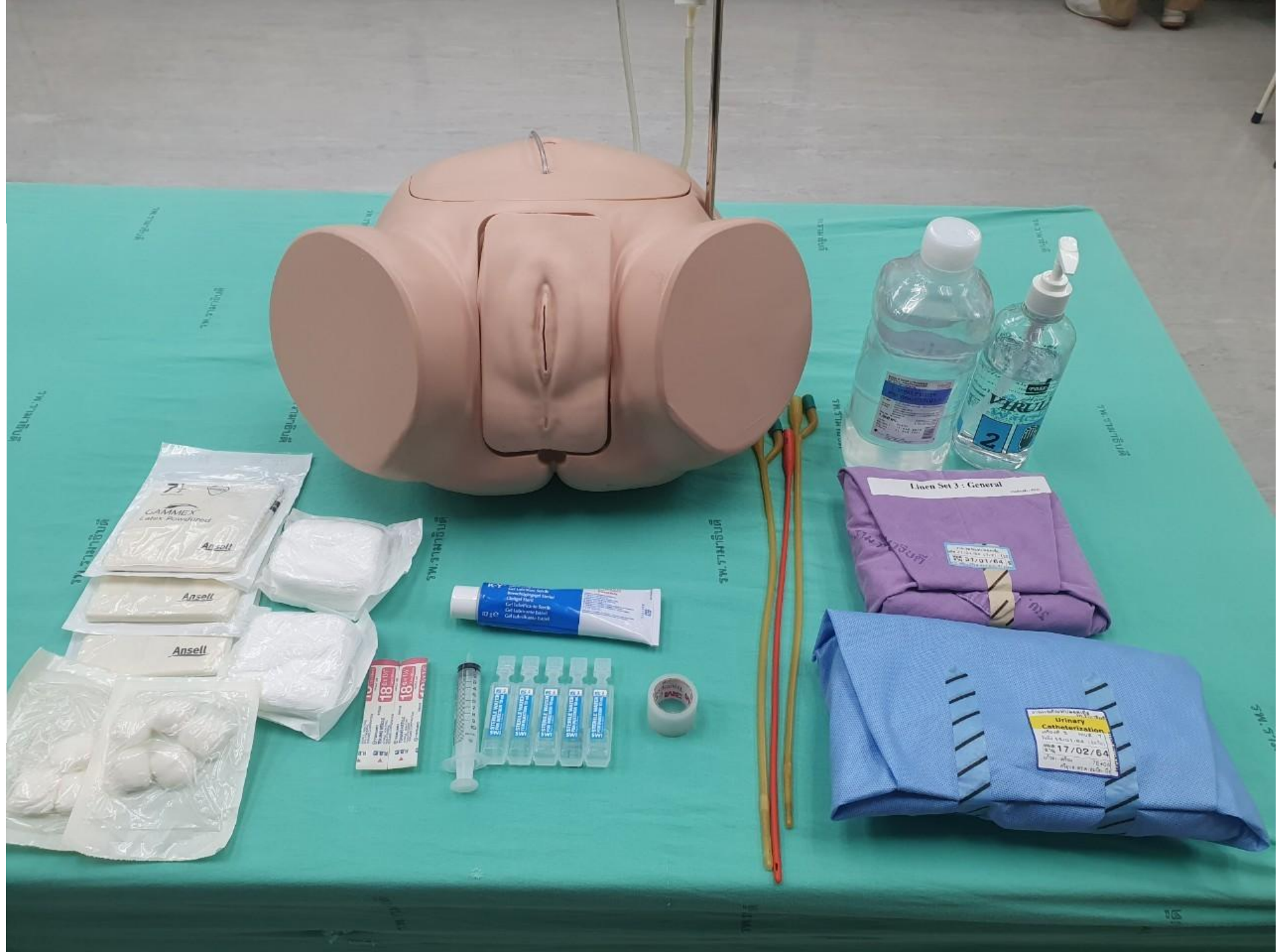


ใส่ใจผู้ป่วย
(CARING)

“การสวนปัสสาวะที่ถูกต้อง ปลอดภัย
คือการดูแลที่ใส่ใจและเคารพผู้ป่วย”







ขั้นตอนการสวน คุณจากการสาธิตของอาจารย์



การยึดติดในผู้ชาย



การยึดติดในผู้หญิง



ภาวะแทรกซ้อนจากการคาสายสวนปัสสาวะ



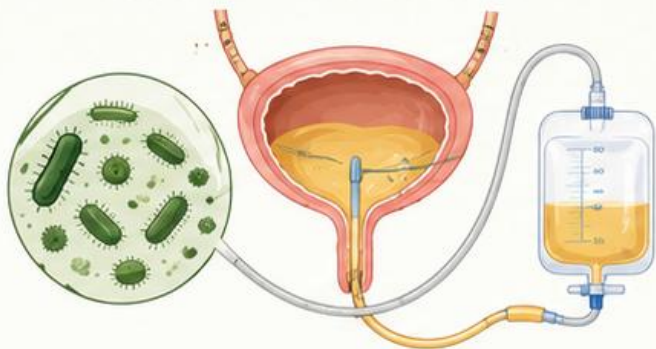
การเฝ้าระวังและป้องกัน ช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายต่อผู้ป่วย



1

การติดเชื้อ (Infection)

ซึ่งอาจเกิดจากความสะอาดของเครื่องมือที่ใช้ในการสวนปัสสาวะไม่ดีพอ หรือจากเทคนิคการสวนปัสสาวะที่ไม่ยึดหลักการปลอดเชื้อ



อาการแสดงที่พบบ่อย

- ปัสสาวะขุ่น มีกลิ่นเหม็น
- มีไข้หนาวสั่น
- ปวดแสบขัดขณะปัสสาวะ
- ปวดหน่วงท้องน้อย



การป้องกัน

- ✓ ยึดหลักปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด
- ✓ ล้างมือก่อน-หลังปฏิบัติ
- ✓ ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์และระบบระบายปัสสาวะ
- ✓ ดูแลสายสวนและรอบรูเปิดให้สะอาดอยู่เสมอ

2

เกิดการชอกช้ำ (Trauma) หรือเกิดการอักเสบของท่อทางเดินปัสสาวะ (Urethritis)

เนื่องจากการเลือกใช้น้ำขนาดของสายสวนไม่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย มีการเกร็งหรือมีแรงต้านในขณะที่ใส่สายสวนปัสสาวะ ทำให้มีการใส่ลำบาก การใส่สายสวนขาดความนุ่มนวล เช่น ใส่อย่างรวดเร็ว ใช้แรงตึงสายอย่างแรง ในขณะที่มีแรงต้าน หรือผู้ป่วยดิ้นขณะใส่สายสวนปัสสาวะ หรือการไม่ใช้พลาสติกตรึงตำแหน่งสายสวนปัสสาวะ ในกรณีใส่สายสวนคา



อาการแสดงที่พบบ่อย

- ปวดแสบขัดขณะปัสสาวะ
- ปวดบริเวณท่อปัสสาวะหรือปลายอวัยวะเพศ
- มีเลือดปนในปัสสาวะ
- รู้สึกไม่สบายตัว



การป้องกัน

- ✓ เลือกสายสวนขนาดเหมาะสมกับผู้ป่วย
- ✓ ใส่สายสวนอย่างนุ่มนวล ไม่เร่งรีบและไม่ใช้แรง
- ✓ หากมีแรงต้าน ให้หยุดและปรับท่าหรือให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย
- ✓ ตรึงสายสวนด้วยพลาสติกอย่างถูกต้อง (กรณีใส่สายสวนคา)

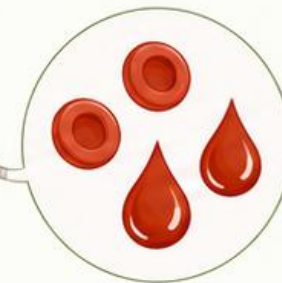


หากมีอาการปวดมากหรือใส่ไม่ได้ ให้หยุดและรายงานแพทย์ทันที

3

ปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria)

ซึ่งมักเกิดจากการใส่สายสวนด้วยความรุนแรง



อาการแสดงที่พบบ่อย

- ปัสสาวะสีชมพู แดง หรือมีเลือดปน
- อาจมีลิ่มเลือดตกปน
- ปวดหน่วงท้องน้อย



การป้องกัน

- ✓ ใส่สายสวนอย่างนุ่มนวล
- ✓ ไม่ใช้แรงดันหรือฝืนใส่สาย
- ✓ เลือกขนาดสายสวนที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
- ✓ สังเกตลักษณะปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ

การดูแลอย่างปลอดภัย



ล้างมือ
ทุกครั้ง



ยึดหลักปลอดเชื้อ
อย่างเคร่งครัด



เลือกขนาดสายสวน
ให้เหมาะสม



ตรึงสายสวน
ให้มั่นคง



ดูแลความสะอาดระบบ
ระบายปัสสาวะ



สังเกตอาการผิดปกติ
และรายงานแพทย์ทันที



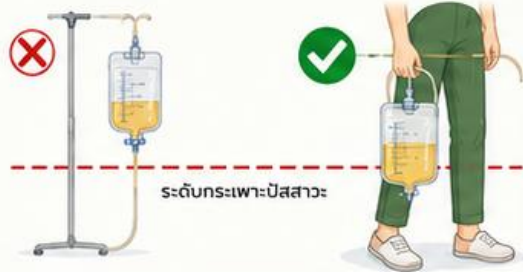
คำแนะนำการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ

ดูแลถูกวิธี ลดการติดเชื้อ ปลอดภัย และช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ



1 ไม่ยกถุงปัสสาวะสูงกว่าระดับกระเพาะปัสสาวะ

เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ และแนะนำวิธีการหิ้วถุงน้ำปัสสาวะเมื่อลุกนั่งหรือเดิน (กรณีช่วยเหลือตนเองได้)



2 ดูแลเพื่อป้องกันการอุดตันของระบบการระบายน้ำปัสสาวะ

จากการพับหักของสายสวนปัสสาวะ ส่งเสริมให้มีการระบายของน้ำปัสสาวะเป็นไปโดยสะดวก โดยมีการระบายตามแรงดึงดูดของโลก



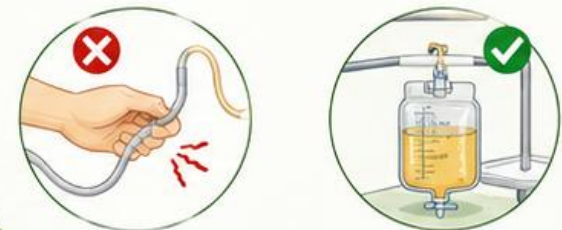
3 ดื่มน้ำมาก ๆ วันละ 2,500-3,000 มล. (หากไม่ขัดต่อโรคและแผนการรักษา)

เพื่อชะล้างทางเดินปัสสาวะภายใน ป้องกันการติดเชื้อ และทำให้ปัสสาวะเจือจาง ไม่เกาะติดกับสายยาง ช่วยพาของเสียออกทางน้ำปัสสาวะได้



4 ห้ามดึงสายสวนปัสสาวะออกเอง และดูแลระบบให้ปลอดภัยเสมอ

การดึงสายสวนออกเองจะทำให้ท่อทางเดินปัสสาวะฉีกขาดหรือได้รับอันตราย ไม่ปล่อยถุงปัสสาวะสัมผัสพื้น และต้องดูแลให้เป็น close system เสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเข้าสู่ทางเดินปัสสาวะ



5 ตรึงสายสวนปัสสาวะให้มั่นคง ห้ามดึงสายสวนออกเอง

เพื่อให้สายอยู่กับที่ ลดการระคายเคืองท่อปัสสาวะ หากดึงสายออกเองจะทำให้เลือดออก และเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น



6 รักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ และรอบรูเปิดท่อปัสสาวะ

ฟอกและล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พยาบาลควรดูแลทำความสะอาดให้



ทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลัง ทุกครั้ง

7 ฝึกหัดบริหารกล้ามเนื้อบีบ

โดยการเกร็งกล้ามเนื้อสะโพกพร้อมกับขมิบกกล้ามเนื้อทวารหนักวันละมากกว่า 100 ครั้ง เพื่อให้กล้ามเนื้อหูรูดทำหน้าที่ได้ดี เมื่อถอดสายสวนปัสสาวะแล้วจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลั้นปัสสาวะได้ตามปกติ



เกร็งค้าง 5-10 วินาที แล้วคลาย 5-10 วินาที

ทำอย่างสม่ำเสมอ ทุกวัน

8 สังเกตตนเอง ฝ้าระวังภาวะติดเชื้อ

เช่น ภาวะไข้ ลักษณะสี และจำนวนของน้ำปัสสาวะ หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้งพยาบาล เพื่อประเมินและพิจารณาให้การพยาบาล หรือรายงานแพทย์ทราบต่อไป



ไม่ปล่อยไว้ รีบแจ้งพยาบาลทันที

เพิ่มเติม



ล้างมือทุกครั้ง ก่อนและหลังสัมผัสสายสวนหรือถุงปัสสาวะ



ดูแลผิวหนังรอบตำแหน่งที่ยึดสายสวนให้สะอาด และแห้งอยู่เสมอ



เปลี่ยนถุงรองรับปัสสาวะตามคำแนะนำของพยาบาล หรือเมื่อสกปรก



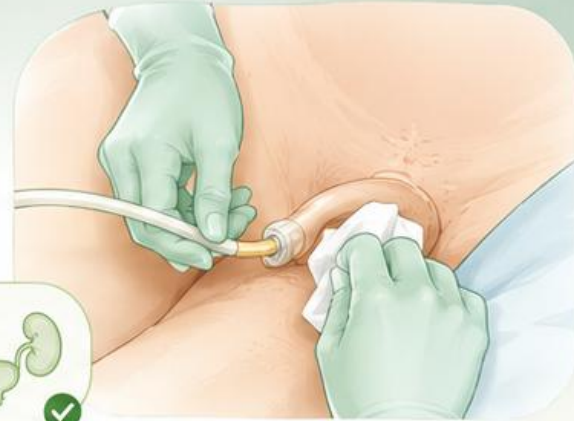
การดูแลที่ถูกต้องทุกวัน ช่วยให้ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อน และฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น





การถอดสายสวนปัสสาวะ

เมื่อหมดความจำเป็นของการคาสายสวนปัสสาวะ แพทย์จะมีคำสั่งให้เอาสายสวนปัสสาวะออก
พยาบาลจะต้องรีบดำเนินการทันทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย



อุปกรณ์การถอดสายสวนปัสสาวะออก



1

อุปกรณ์ทำความสะอาด อวัยวะสืบพันธุ์



- ใช้สำหรับทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ก่อนและหลังการถอดสายสวนปัสสาวะ
- ช่วยลดการติดเชื้อ และรักษาความสะอาด

2

กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อ ขนาด 10 ซีซี.



- ใช้สำหรับดูดน้ำออกจากบอลลูน (ถ้ามี) ก่อนถอดสายสวนปัสสาวะ
- เพื่อให้สามารถดึงสายออกได้อย่างปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

3

ถุงมือสะอาด จำนวน 2 คู่



- ใช้สวมใส่เพื่อความสะดวก และป้องกันการติดเชื้อ
- คู่แรก สำหรับถอดสายสวนปัสสาวะ คู่ที่สอง สำหรับทำความสะอาด

4

ภาชนะสะอาด สำหรับรองรับปัสสาวะ

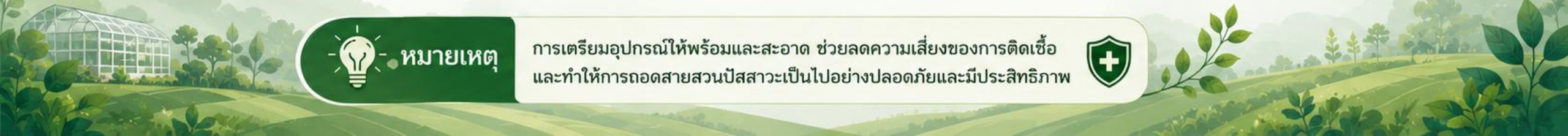


- ใช้สำหรับรองรับปัสสาวะหลังการถอดสายสวน
- ช่วยป้องกันการเปื้อน และรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม



หมายเหตุ

การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและสะอาด ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และทำให้การถอดสายสวนปัสสาวะเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ





ขั้นตอนการถอดสายสวนปัสสาวะ



ปลอดภัย สะอาด ลดการติดเชื้อ ดูแลด้วยหัวใจห่วงใยผู้ป่วย



ขั้นตอนการปฏิบัติ

เหตุผล

- 1 เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน



เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดการปนเปื้อนขณะปฏิบัติการ

- 2 แจ้งและอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงเหตุผลในการถอดสายสวนปัสสาวะออก



เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจ ลดความวิตกกังวล และให้ความร่วมมือ

- 3 ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่ทำลายเชื้อ



เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

- 4 สวมถุงมือสะอาด



เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการสัมผัสสารคัดหลั่ง

- 5 ขำระล้างอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่



เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคบริเวณปากท่อปัสสาวะ

- 6 ถอดถุงมือคู่เดิมออก



เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

- 7 ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่ทำลายเชื้อ หรือ Alcohol hand rub



เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

- 8 สวมถุงมือสะอาดคู่ที่ 2



เพื่อรักษาความสะอาด ก่อนทำการตัดการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

เหตุผล

- 9 วางภาชนะสะอาดไว้บริเวณระหว่างขาผู้ป่วยเพื่อรองรับปัสสาวะในกรณีที่มีปัสสาวะตกค้าง



เพื่อป้องกันการเปื้อน และรักษาความสะอาด

- 10 ต่อกะบอกฉีดยาปราศจากเชื้อกับปลายสายสวนปัสสาวะทางหางที่เป็นแถบสี ดูดน้ำล้นออกจากลูกโป่งให้หมด (ช่วงแรกควรปล่อยให้น้ำดันกระบอกฉีดยาออกมาเอง)



เพื่อให้บอลูนแฟบ และสามารถถอดสายสวนได้ โดยไม่ทำอันตรายต่อท่อปัสสาวะ

- 11 หักสายสวนปัสสาวะไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัสสาวะไหล แล้วค่อย ๆ ดึงสายสวนออกอย่างเบามือและช้า ๆ เนื่องจากผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บขณะดึงสายสวนออก ควรบอกให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกยาว ๆ



เพื่อป้องกันการหกละเออะ ลดการบาดเจ็บ และช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย

- 12 ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกอีกครั้ง



เพื่อความสะดวกและลดการสะสมของเชื้อโรค

- 13 ถอดถุงมือและล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่ทำลายเชื้อ



เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

- 14 ถ้ามีการบันทึกปริมาณปัสสาวะ จะต้องบันทึกปริมาณปัสสาวะในถุงปัสสาวะทั้งหมดก่อนนำไปทิ้ง



เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาวะสมดุลน้ำของผู้ป่วย

- 15 ภายหลังการยกเลิกการคาสายสวนปัสสาวะ พยาบาลจะต้องสังเกตและให้การช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถถ่ายปัสสาวะได้เองภายใน 6-8 ชั่วโมง



เพื่อประเมินการกลับมาทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ

หมายเหตุ



ยึดหลักความสะอาด ปลอดภัยทุกขั้นตอน



ป้องกันการติดเชื้อ คือหัวใจสำคัญ



อธิบาย ให้ความเข้าใจ ใส่ใจผู้ป่วยเสมอ



สังเกตอาการและรายงาน ความผิดปกติทันที





ข้อควรระวัง

การดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ



ดูแลอย่างถูกวิธี ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อน



1

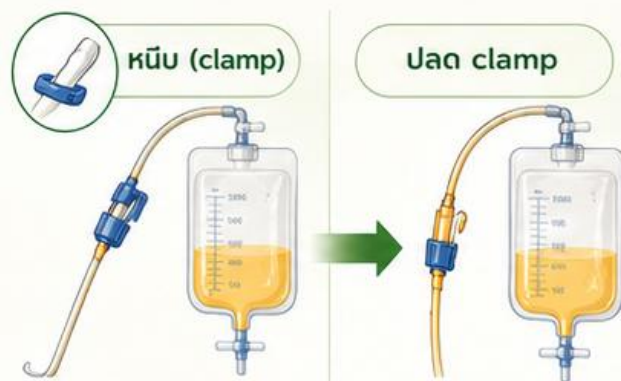
เทปัสสาวะทิ้งอย่างน้อย
ทุก 4-8 ชั่วโมง
หรือก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย



เพื่อป้องกันการติดเชื้อของสายสวน
ปัสสาวะจากน้ำหนักของน้ำปัสสาวะ

2

ขณะพลิกตะแคงตัวหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ควรใช้ clamp หนีบสายของถุงรองรับปัสสาวะ



เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำปัสสาวะ
และปลด clamp ทันทีเมื่อเคลื่อนย้ายเสร็จแล้ว

3

เปลี่ยนฟลัสเตอร์และตำแหน่ง
การติดฟลัสเตอร์ทุกวัน
และตรวจดูการติดฟลัสเตอร์ทุกครั้ง
ก่อนพลิกตะแคงตัว



เปลี่ยนทุกวัน

ตรวจทุกครั้ง

เพื่อป้องกันการเกิดแผลบริเวณที่ติดฟลัสเตอร์
และป้องกันการบาดเจ็บ การติดเชื้อ และการอุดตัน
จากการที่สายสวนปัสสาวะด้านนอกเลื่อนเข้า-ออก
ซึ่งอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ทางเดินปัสสาวะ

4

หากมีปัสสาวะรั่วออกในขณะที่คาสายสวนปัสสาวะ
ยังไม่ควรเติมน้ำใน balloon ควรหาสาเหตุก่อน



เช่น สายอาจหักพับ
จากการจัดท่า แต่ถ้าหาสาเหตุ
ไม่พบ ให้เติมน้ำในบอลูนออกมา
ดูว่าเหลือครบตามจำนวนที่ใส่ไว้หรือไม่



ถ้าปริมาณน้ำไม่ครบตามจำนวนที่ใส่ไว้
ห้ามเติมน้ำเข้าไปใน balloon เพราะสายสวน
อาจเลื่อนลงมาถึงท่อทางเดินปัสสาวะ
ให้เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะเส้นใหม่



ถ้าน้ำในบอลูนครบตามจำนวนที่ใส่ไว้
แต่ยังมีปัสสาวะรั่วอยู่ ควรเปลี่ยนสายสวน
ปัสสาวะให้มีขนาดเล็กกว่าเดิม เพื่อให้
กล้ามเนื้อหูรูดของทางเดินปัสสาวะหดเล็กลง
ช่วยลดการรั่วซึม



ดูแลอย่างสม่ำเสมอ ปลอดภัย ลดปัญหา



รักษาความสะอาด
ของอุปกรณ์และร่างกาย
ให้สม่ำเสมอ



ดื่มน้ำให้เพียงพอ
ตามคำแนะนำแพทย์



สังเกตความผิดปกติ
ของปัสสาวะและ
อาการของผู้ป่วย



หากมีข้อสงสัย
หรืออาการผิดปกติ
รีบแจ้งพยาบาล



การดูแลที่ถูกต้อง
ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัย
และหายเร็วขึ้น





การใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ

ปลอดภัย สะดวก ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ



ผู้ชายที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ การใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะเป็นวิธีที่ดี เนื่องจากการใส่ถุงยางอนามัยไม่มีความเสี่ยงของการนำเชื้อโรคเข้าสู่ทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเป็นการประยุกต์เพื่อระบายปัสสาวะให้ผู้ป่วยได้

ขั้นตอนการเตรียมถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ

1 สวมถุงยางอนามัยด้านปลายที่เป็นกระเปาะเข้ากับท่อระบายปัสสาวะของกระเปาะ ห่างจากปลายท่อประมาณ 2 นิ้ว ให้แน่นเป็น 2 ปล้อง เพื่อป้องกันปัสสาวะรั่วซึมออกข้าง ๆ



2 ดัดบริเวณปลายกระเปาะของถุงยางอนามัยให้มีรูเปิดเพื่อเป็นช่องทางให้ปัสสาวะไหลลงสู่ท่อระบายได้



3 พันดัดถุงยางอนามัยให้หุ้มปลายท่อที่เป็นรูเปิด พันพลาสติกเข้ากับปลายถุงยางอีกครั้งตรงตำแหน่งเดียวกันกับที่พันพลาสติกครั้งแรก



4 คลี่ถุงยางอนามัยเพื่อเตรียมไว้สวมหุ้มองคชาติ ส่วนปลายท่อระบายอีกด้านต่อกับถุงรองรับปัสสาวะ



วิธีใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ

วิธีปฏิบัติ

เหตุผล

1 อธิบายเหตุผลและวิธีการทำให้ผู้ป่วยทราบ



เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือ

2 จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย คลุมผ้าให้เรียบร้อย เปิดเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์

เปิดเผยผู้ป่วยเท่าที่จำเป็น เป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

3 ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์และบริเวณโดยรอบให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ เช็ดให้แห้ง - ประเมินบริเวณองคชาติว่ามีรอยถลอก บวมแดงหรือไม่ ถ้ามีรอยถลอก บวมแดงจะงดใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ บางสถาบันอาจให้โกนขนที่อวัยวะสืบพันธุ์ในรายที่จะสวมถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ ซึ่งต้องโกนขนก่อนทำความสะอาด

เพื่อให้สะอาดป้องกันการติดเชื้อ ผู้ป่วยรู้สึกสบาย เนื่องจากปัสสาวะที่อยู่ภายในถุงยางอนามัยมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน จะยิ่งทำให้องคชาติมีการอักเสบยิ่งขึ้น เพื่อยึดถุงยางอนามัยโดยไม่ให้นูนติดพลาสติก ซึ่งจะเจ็บเวลาออกพลาสติกออก

4 สวมถุงยางอนามัยที่ต่อกับถุงรองรับปัสสาวะไว้แล้วเข้ากับปลายองคชาติของผู้ป่วย หุ้มถึงโคนโดยไม่ต้องร่นหนังหุ้มปลายองคชาติ



เพื่อทำการระบายปัสสาวะให้ไหลลงถุงรองรับปัสสาวะ

5 จัดให้ถุงยางอนามัยส่วนที่ต่อกับท่อระบายห่างจากปลายสุดขององคชาติ 1-2 นิ้ว



ป้องกันองคชาติเสียดสีกับปลายสายยาง และไม่ให้ปัสสาวะระคายเคืองเนื้อเยื่อองคชาติ

6 พันพลาสติกรอบถุงยางอนามัยให้ติดกับโคนองคชาติให้เป็นรอบเกลียว ไม่ติดเป็นวงกลม โดยไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไป



การพันเป็นวงกลมและแน่นเกินไปจะทำให้ผู้ป่วยไม่สบาย และองคชาติขาดเลือดมาเลี้ยง ส่วนการพันหลวมๆ จะทำให้หลุดง่าย

7 แขนงถุงรองรับปัสสาวะในระดับต่ำกว่าตัวผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่ลุกเดินได้ ให้ติดถุงรองรับปัสสาวะกับต้นขาด้านในหรือจัดใส่ภายในให้ผู้ป่วยถือเดินได้



เพื่อผู้ป่วยจะได้เคลื่อนไหวได้ตามปกติ

8 บันทึกวันเวลาการใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ และลักษณะผิวหนังบริเวณองคชาติในวันบันทึกทางการแพทย์



สื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นประโยชน์ในการดูแล และการประเมินผลและเป็นหลักฐานการปฏิบัติการพยาบาล

⚠ ข้อควรระวัง

1



เทปสวาทึงอย่างน้อยทุก 4-8 ชั่วโมง หรือก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อป้องกันการดึงรั้งของสายสวนปัสสาวะจากน้ำหนักของน้ำปัสสาวะ

2



ในขณะที่มีการพลิกตะแคงตัวหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ควรใช้ clamp ทำการหนีบสายของถุงรองรับปัสสาวะ ขณะเคลื่อนย้ายถุง เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำปัสสาวะ และปลด clamp ทันทีเมื่อเคลื่อนย้ายเสร็จแล้ว

3



ควรเปลี่ยนพลาสติกและตำแหน่งของการติดพลาสติกทุกวัน เพื่อป้องกันการเกิดแผลบริเวณที่ติดพลาสติก และตรวจดูการติดพลาสติกทุกครั้งก่อนพลิกตะแคงตัว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การดึงรั้ง และการติดเชื้อจากการที่สายสวนปัสสาวะด้านนอกเลื่อนเข้า-ออก ซึ่งอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ทางเดินปัสสาวะ

4



หากมีปัสสาวะรั่วออกในขณะที่คาสายสวนปัสสาวะ ยังไม่ควรเพิ่มน้ำใน balloon ควรหาสาเหตุก่อน เช่น สายอาจหักพับจากการจัดท่า แต่ถ้าหาสาเหตุไม่พบ ให้เติมน้ำในบอลูนออกมาดูว่าเหลือครบตามจำนวนที่ใส่ไว้หรือไม่

- ถ้าปริมาณน้ำไม่ครบตามจำนวนที่ใส่ไว้ ห้ามเพิ่มน้ำเข้าไปใน ballon เพราะสายสวนอาจเลื่อนลงมาถึงท่อทางเดินปัสสาวะ ให้เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะเส้นใหม่
- ถ้าปริมาณน้ำครบตามจำนวนที่ใส่ไว้ แต่ยังมีปัสสาวะรั่วอยู่ ควรเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะให้มีขนาดเล็กกว่าเดิม เพื่อให้ง่ายต่อการสอดใส่ของทางเดินปัสสาวะหดเล็กลง ช่วยลดการรั่วซึม



Connect the urine bag to the condom



Insert the connection completely and check if it falls off



Assist users to wear condoms





การดูแลผู้ป่วยขณะใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ และการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ



สะอาด ปลอดภัย ลดการติดเชื้อ ดูแลอย่างใส่ใจทุกขั้นตอน



การดูแลผู้ป่วยขณะใส่ถุงยางอนามัยเพื่อระบายปัสสาวะ

ถุงยางอนามัยทำด้วยวัสดุบางเบาอาจมีโอกาสดูดซับเป็นเกลียวบริเวณรอยต่อของถุงยางอนามัย และท่อระบาย ทำให้เกิดการอุดตันและปัสสาวะขังอยู่ในถุงหรือนำรั่วซึม ดังนั้นต้องตรวจดูเป็นระยะ นอกจากนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณผิว เช่น ผื่นจุดตากบวมหรือมีรอยถลอกเนื่องจากการระคายเคืองปัสสาวะ ดังนั้นจึงต้องประเมินทุกวันและเปลี่ยนถุงยางอนามัยเพื่อทำความสะอาดทุกวัน ด้วยสบู่และน้ำ หากมีอาการผิดปกติให้งดใส่ชั่วคราวและรายงานแพทย์ให้ทราบ



การดูแลประจำวัน



ตรวจดูรอยต่อของ
ถุงยางอนามัยและท่อระบาย
ไม่ให้บิดหมุนหรืออุดตัน



ตรวจสอบการไหลของปัสสาวะ
ในถุงรองรับอย่างสม่ำเสมอ
ไม่มีรั่วซึม



ทำความสะอาดอวัยวะเพศ
ด้วยสบู่และน้ำทุกวัน



ประเมินสภาพผิวหนังบริเวณ
อวัยวะเพศทุกวัน ว่ามีบวม
แดง รอยถลอก หรือระคายเคือง



เปลี่ยนถุงยางอนามัย
และทำความสะอาดทุกวัน
หรือเมื่อมีการรั่วซึม

ข้อควรระวัง



หากพบอาการบวมแดง รอยถลอก
หรือระคายเคืองมาก
ให้งดใส่ชั่วคราว



รายงานแพทย์ทันที
หากมีอาการผิดปกติ เช่น
ปัสสาวะรั่วมาก อุดตัน มีไข้



ป้องกันการดึงรั้งสาย
และจัดถุงรองรับให้อยู่ต่ำกว่าระดับ
กระเพาะปัสสาวะเสมอ



ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ
ในการดูแลและสังเกตอาการ
อย่างต่อเนื่อง

การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ



การตรวจปัสสาวะสิ่งที่ควรระมัดระวังคือการมีสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะไปปนเปื้อนในปัสสาวะได้ ซึ่งทำให้ผลการตรวจปัสสาวะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากความเป็นจริงได้

1

ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ตรงกับผู้รับบริการ
ให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ข้างกระปุก



ชื่อ-สกุล.....
HN
วันที่.....



2

แนะนำผู้รับบริการล้างมือให้สะอาด
ก่อนทำการเก็บปัสสาวะ



3

การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ควรเลือกเก็บ
เฉพาะน้ำปัสสาวะเฉพาะช่วงกลาง โดยให้
ปัสสาวะในช่วงแรกและช่วงท้ายทิ้งไป
ปริมาณการเก็บประมาณ 30-60 มิลลิตร (1-2 ออนซ์)



ปัสสาวะช่วงแรก
ทิ้งไป



เก็บปัสสาวะ
ช่วงกลาง



ปัสสาวะช่วงท้าย
ทิ้งไป



4

ปิดฝากระปุก
แล้วล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง



5

ตรวจดูความสะอาดบริเวณรอบภาชนะ
และปิดฝาให้เรียบร้อย



การดูแลอย่างถูกต้อง = ลดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มความสบายของผู้ป่วย



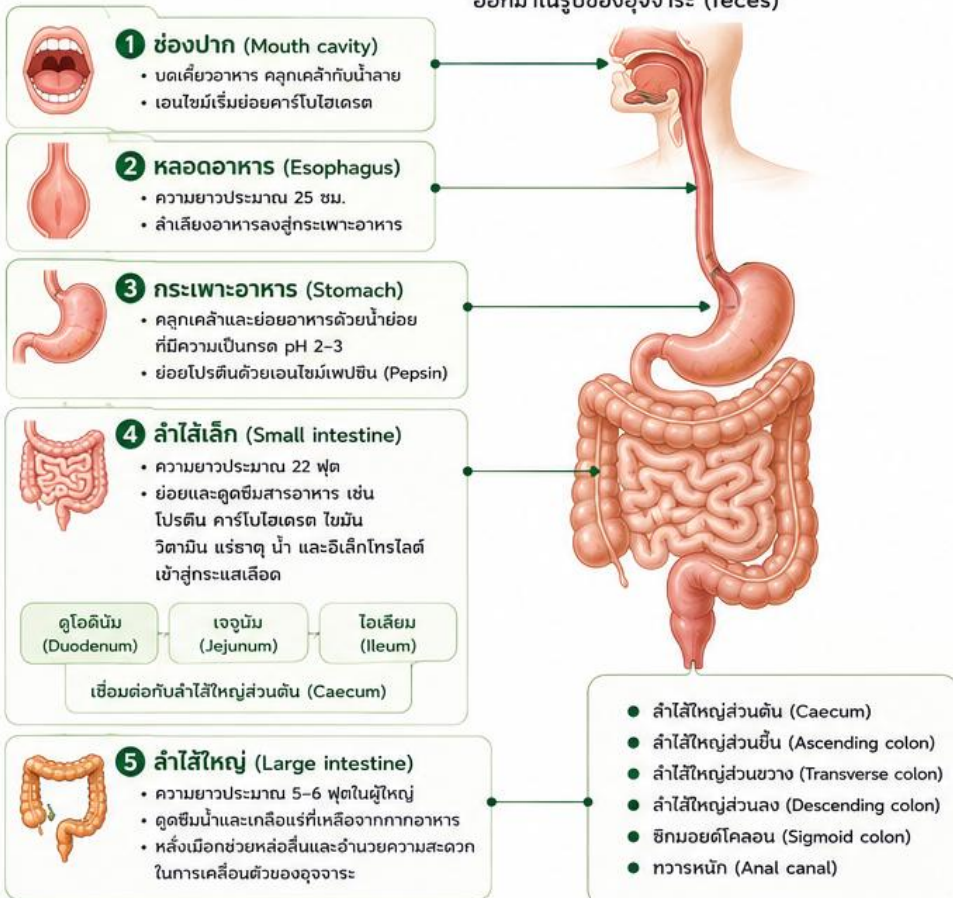
เก็บอย่างถูกวิธี ผลตรวจแม่นยำ ไร้การปนเปื้อน



2. การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ

2.1 กระบวนการขับถ่ายอุจจาระ

การขับถ่ายอุจจาระเป็นกระบวนการสำคัญของร่างกายที่เกิดขึ้นหลังจากการรับประทานอาหาร ร่างกายจะทำการย่อย ดูดซึมสารอาหารที่จำเป็น และกำจัดกากอาหารหรือสิ่งที่ไม่ต้องการออกมาในรูปของอุจจาระ (feces)



หน้าที่สำคัญของลำไส้ใหญ่ คือการดูดซึมน้ำและเกลือแร่ที่เหลือ ทำให้กากอาหารจับตัวเป็นอุจจาระ พร้อมทั้งหล่อลื่นและอำนวยความสะดวกในการขับถ่าย

กลไกการขับถ่ายอุจจาระ



หมายเหตุ

หากยังไม่ได้ถ่ายอุจจาระในช่วงเวลานั้น มวลกากอาหารในลำไส้ตรงมักถูกบีบตัวกลับคืนไปยังลำไส้ใหญ่ น้ำจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ผนังลำไส้ กากอาหารจึงแห้งและแข็งขึ้น



ผลจากความสมดุลของน้ำในลำไส้

ท้องผูก (Constipation)



- เวลาในการบีบตัวอย่างแรงของลำไส้ใหญ่ส่วนขวางและส่วนลงเกิดขึ้น 1-2 ครั้งต่อวัน หรือน้อยกว่า
- ไม่ได้ถ่ายอุจจาระอีก น้ำจะถูกดูดซึมไปอีก
- มวลของอุจจาระที่ค้างอยู่แห้งและแข็ง
- อุจจาระแข็ง เป็นก้อน แห้ง ถ่ายยาก

สาเหตุที่พบบ่อย



ดื่มน้ำน้อย



ใยอาหารน้อย



ไม่ออกกำลังกาย



กลืนอุจจาระบ่อย

ท้องร่วง (Diarrhea)



- ช่วงเวลาที่กากอาหารผ่านเข้าสู่ลำไส้ตรงสั้น
- ขับถ่ายออกเร็ว
- มีน้ำปนอยู่ในอุจจาระมาก
- น้ำไม่ถูกดูดซึมเข้าผนังลำไส้
- อุจจาระเหลว หรือน้ำปนบ่อยครั้ง

สาเหตุที่พบบ่อย



ติดเชื้อ



อาหารเป็นพิษ



ยาบางชนิด



ความเครียด



การดูแลสำคัญ



ดื่มน้ำให้เพียงพอ



รับประทานอาหารให้เพียงพอ



ออกกำลังกายสม่ำเสมอ



ไม่กลืนอุจจาระ



สังเกตการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่าย



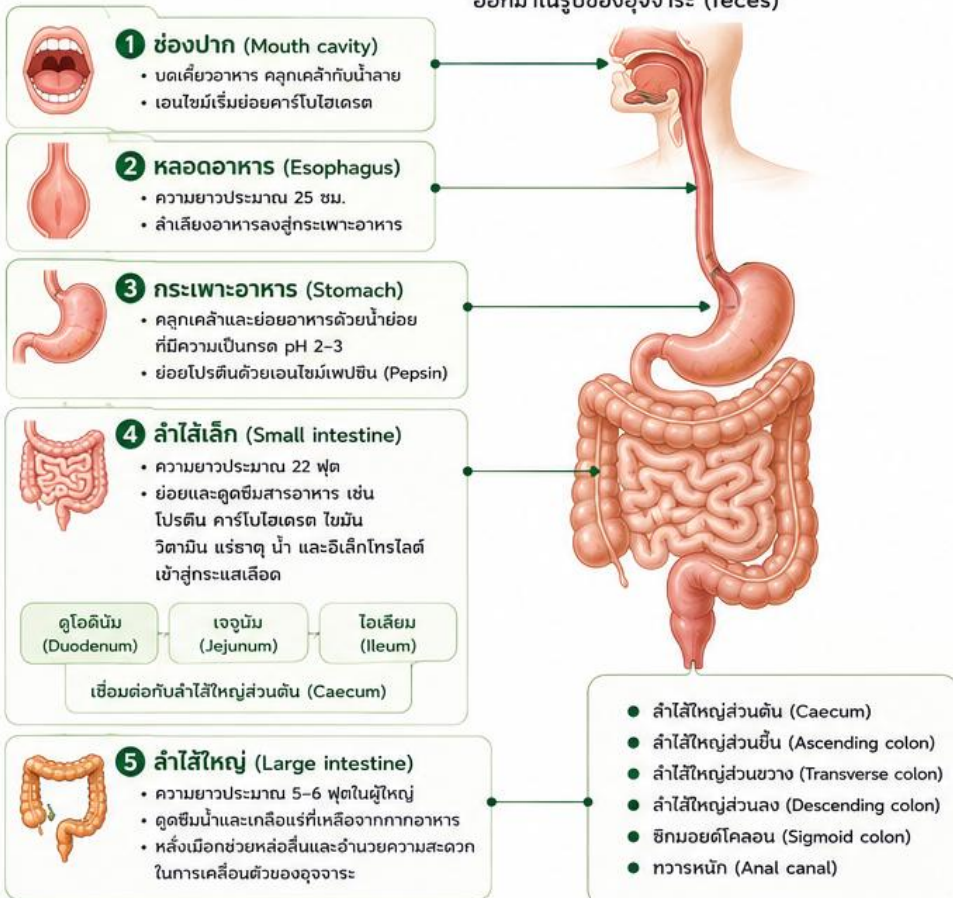
หากผิดปกติรุนแรง ควรพบแพทย์



2. การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายอุจจาระ

2.1 กระบวนการขับถ่ายอุจจาระ

การขับถ่ายอุจจาระเป็นกระบวนการสำคัญของร่างกายที่เกิดขึ้นหลังจากการรับประทานอาหาร ร่างกายจะทำการย่อย ดูดซึมสารอาหารที่จำเป็น และกำจัดกากอาหารหรือสิ่งที่ไม่ต้องการ ออกมาในรูปของอุจจาระ (feces)



หน้าที่สำคัญของลำไส้ใหญ่ คือการดูดซึมน้ำและเกลือแร่ที่เหลือ ทำให้กากอาหารจับตัวเป็นอุจจาระ พร้อมทั้งหล่อลื่นและอำนวยความสะดวกในการขับถ่าย

กลไกการขับถ่ายอุจจาระ



หมายเหตุ

หากยังไม่ได้ถ่ายอุจจาระในช่วงเวลานั้น มวลกากอาหารในลำไส้ตรงมักถูกบีบตัวกลับคืนไปยังลำไส้ใหญ่ น้ำจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ผนังลำไส้ กากอาหารจึงแห้งและแข็งขึ้น



ผลจากความสมดุลของน้ำในลำไส้

ท้องผูก (Constipation)



- เวลาในการบีบตัวอย่างแรงของลำไส้ใหญ่ส่วนขวางและส่วนลงเกิดขึ้น 1-2 ครั้งต่อวัน หรือน้อยกว่า
- ไม่ได้ถ่ายอุจจาระอีก น้ำจะถูกดูดซึมไปอีก
- มวลของอุจจาระที่ค้างอยู่แห้งและแข็ง
- อุจจาระแข็ง เป็นก้อน แห้ง ถ่ายยาก

สาเหตุที่พบบ่อย



ดื่มน้ำน้อย



ใยอาหารน้อย



ไม่ออกกำลังกาย



กลืนอุจจาระบ่อย

ท้องร่วง (Diarrhea)



- ช่วงเวลาที่กากอาหารผ่านเข้าสู่ลำไส้ตรงสั้น
- ขับถ่ายออกเร็ว
- มีน้ำปนอยู่ในอุจจาระมาก
- น้ำไม่ถูกดูดซึมเข้าผนังลำไส้
- อุจจาระเหลว หรือน้ำปนบ่อยครั้ง

สาเหตุที่พบบ่อย



ติดเชื้อ



อาหารเป็นพิษ



ยาบางชนิด



ความเครียด



การดูแลสำคัญ



ดื่มน้ำให้เพียงพอ



รับประทานอาหารให้เพียงพอ



ออกกำลังกายสม่ำเสมอ



ไม่กลืนอุจจาระ



สังเกตการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่าย



หากผิดปกติรุนแรง ควรพบแพทย์



2.2.1.3 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูก

ประกอบด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยา การใช้ยา และการสวนอุจจาระ



1) วิธีที่ไม่ใช้ยา



(1) อาหาร

- รับประทานอาหารที่มีใยอาหารมาก เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวซ้อมมือ มะเขือขื่นต่างๆ มะระ ผักกาด ผักคะน้า เป็นต้น
- อาหารที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย เช่น มะขาม มะละกอสุก ลูกพรุน ส้ม กล้วยน้ำว้า รับประทานผลไม้สดดีกว่าคั้นเฉพาะน้ำ



(2) น้ำ

- ดื่มน้ำให้เพียงพอ วันละ 2,000–2,500 มิลลิลิตร หากไม่มีข้อห้ามที่ต้องจำกัดน้ำ
- เตรียมน้ำดื่มไว้ใกล้มือ ช่วยรีน ป้อน หรือจัดหลอดดูดตามสภาพผู้ป่วย
- บันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออกจากร่างกาย



(3) ช่วยเหลือการถ่ายอุจจาระ

- แนะนำให้ถ่ายเมื่อรู้สึกปวด ไม่กลั้น
- ช่วยพาไปห้องน้ำ หรือจัดให้ Commode chair หรือถ่ายบนหมอนบอน ตามสภาพผู้ป่วย
- จัดให้ปลอดภัย เป็นส่วนตัว ไม่เร่งรีบ
- เข้าไปดูเป็นระยะ และให้กำลังใจเมื่อเสร็จ



(4) การฝึกถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา

- ฝึกให้ถ่ายเป็นเวลา โดยเฉพาะช่วงเช้า หลังอาหารเช้า
- ช่วยสร้างสุขนิสัยการขับถ่ายที่ต่อเนื่อง



(5) การออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกาย

- ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้
- เดินไปมา เดินรอบเตียง ลุกนั่ง พลิกตัว ขยับแขนขา ตามสภาพที่ทำได้
- หากทำไม่ได้มาก ให้นวดหน้าท้อง เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง หรือเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ



2) การใช้ยา

ใช้เมื่อวิธีไม่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผล หรือแพทย์สั่งเพื่อป้องกันการเบ่งถ่าย เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ หลังผ่าตัด หรือมีแผลที่ทวารหนัก เมื่อให้ยาแล้วควรติดตามผลภายใน 24 ชั่วโมง ถ้ายังไม่ถ่ายอุจจาระ ให้รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาใช้การสวนอุจจาระ

ยาระบายที่ใช้และกลไกการออกฤทธิ์

1	เพิ่มปริมาณอุจจาระ (Bulk forming)	ออกฤทธิ์ภายใน 12 ชั่วโมง	ตัวอย่างยา
	เพิ่มมวลของอุจจาระ พองตัวในลำไส้ ทำให้อุจจาระนุ่มขึ้น ขับถ่ายออกได้ง่าย		• Psyllium • Methylcellulose • Polycarbophil
2	กระตุ้นหรือระคายเคืองที่ผนังลำไส้ (Stimulants, irritants)	ออกฤทธิ์ภายใน 6–12 ชั่วโมง	ตัวอย่างยา
	กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ และการคัดหลั่ง		• น้ำมันมะพร้าว (Caster oil)
3	เพิ่มปริมาณน้ำด้วยแรงดันออสโมติก (Osmotic)	ออกฤทธิ์ภายใน 30 นาที–6 ชั่วโมง	ตัวอย่างยา
	ดึงน้ำเข้าสู่ลำไส้ ทำให้อุจจาระนุ่ม ขับถ่ายออกได้ ผลเร็ว		• Lactulose • Polyethylene glycol • Saline, Magnesium citrate
4	ทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มขึ้น (Emollients, stool softener)	ออกฤทธิ์ภายใน 1–3 วัน	ตัวอย่างยา
	น้ำและไขมันแทรกเข้าไปในอุจจาระ ขับถ่ายออกง่าย		• Docusate sodium • Liquid paraffin
5	หล่อลื่น (Lubricants)	ออกฤทธิ์ภายใน 6–8 ชั่วโมง	ตัวอย่างยา
	เคลือบก้อนอุจจาระ ป้องกันการดูดซึม น้ำ ช่วยให้เคลื่อนผ่านลำไส้ได้ง่าย		• Mineral oil • E.L.P. emulsion of liquid paraffin
6	ยาเหน็บทวารหนัก (Suppositories)	ออกฤทธิ์ภายใน 5–10 นาที	ตัวอย่างยา
	ละลายเร็วในร่างกาย ทำให้อุจจาระนุ่ม และหล่อลื่น ขับถ่ายออกง่าย		• Glycerine suppositories • Dulcolax suppositories

ข้อควรระวังในการใช้ยาระบาย

ไม่ใช้ในผู้ที่มิสำนึกตัว การอักเสบในช่องท้อง	ไม่ใช้ในผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจวาย	ควรใช้ตามคำสั่งแพทย์ ไม่ใช่เป็นประจํา	การใช้บ่อย ทำให้ลำไส้ไม่ทำงานเอง ท้องผูกเรื้อรัง	อาจรบกวนการออกฤทธิ์ ของยาอื่น

3) การสวนอุจจาระ

เมื่อใช้ยาแล้วไม่ได้ผล แพทย์มักให้ใช้การสวนอุจจาระ ซึ่งมีการใช้สารละลายชนิดต่างๆ หรือน้ำสวนสำเร็จรูป

วัตถุประสงค์

- กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้
- ทำให้อุจจาระนุ่มและขับถ่ายออกง่าย
- ช่วยระบายอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้



ชนิดของสารละลายที่ใช้สวนอุจจาระ

- น้ำสะอาด
- น้ำเกลือ 0.9%
- สารละลายฟอสเฟต (Sodium phosphate)
- สารละลายสบู่ (Soap suds)
- สารละลายกลีเซอริน (Glycerin enema)

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบคำสั่งแพทย์ ชนิดและปริมาณสารละลาย
- ตรวจสอบอุณหภูมิสารละลาย (ประมาณ 37–40°C)
- ใช้เทคนิคที่สะอาด ป้องกันการติดเชื้อ
- หลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อักเสบ และคันลำไส้ หรือหลังผ่าตัดระบบทางเดินอาหารบางชนิด
- สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้องมาก คลื่นไส้ เวียนศีรษะ หายใจลำบากและรายงานแพทย์ทันที





2.2.2 การอัดแน่นของอุจจาระ (Fecal impaction)

หมายถึง การอัดแน่นของอุจจาระ เป็นอาการที่สืบเนื่องจากท้องผูก เป็นการสะสมของอุจจาระที่แห้งแข็งมาก
จับเป็นก้อน ขับถ่ายออกเองไม่ได้ อุตันบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง เกิดจากการท้องผูกที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ทำให้น้ำในก้อนอุจจาระถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายเรื่อย ๆ



2.2.2.1 สาเหตุของการอัดแน่นของอุจจาระ

พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว หรืออัมพาตครึ่งล่าง ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่เฉยๆบนเตียงนาน ๆ



ความผิดปกติของระบบ
ประสาทส่วนกลาง



ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว
หรืออัมพาตครึ่งล่าง



ผู้สูงอายุ



ผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่
เฉยๆบนเตียงนาน ๆ

2.2.2.2 ผลของการอัดแน่นของอุจจาระ

ภายหลังไม่ได้ถ่ายอุจจาระติดต่อกันหลายวัน มีการถ่ายเป็นน้ำไหลซึม
ทางทวารหนักอย่างควบคุมไม่ได้



ปวดท้องมาก
ปวดอุจจาระ
อยากถ่ายตลอดเวลา
แต่ถ่ายไม่ออก

ถ่ายเป็นน้ำ
ไหลซึมทางทวารหนัก
อย่างควบคุมไม่ได้

อาการอื่นที่เกิดร่วมด้วย



ท้องอืด แน่น



คลื่นไส้ อาเจียน



หายใจสั้น ๆ



ความดันเลือด
สูงขึ้น



เมื่อตรวจทางทวารหนัก (Rectal exam)

โดยสวมถุงมือและใช้สารหล่อลื่น สอดนิ้วทางทวารหนัก
จะพบก้อนแข็งของอุจจาระ ยกเว้นเมื่อก้อนอุจจาระสูงขึ้นไป



2.2.2.3 การพยาบาลผู้ป่วย ที่มีการอัดแน่นของอุจจาระ



จุดมุ่งหมายสำคัญ
ของการช่วยเหลือผู้ป่วย คือ
การเอาก้อนอุจจาระออกจากร่างกาย
ทางทวารหนัก

1

แพทย์มักสั่งให้ยาระบาย
ที่ช่วยให้ก้อนอุจจาระอ่อนตัว



2

ตามด้วยการสวนล้าง
เพื่อให้อุจจาระอ่อนนุ่ม
และขับออกได้ง่าย



3

หากจำเป็นอาจต้องล้าง
อุจจาระออก



การป้องกัน
สำคัญ



รับประทานอาหาร
ที่มีใยอาหาร



ดื่มน้ำให้เพียงพอ



ออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ



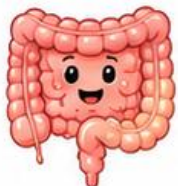
ฝึกขับถ่าย
ให้เป็นเวลา



ดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้ป่วยติดเตียง
อย่างใกล้ชิด

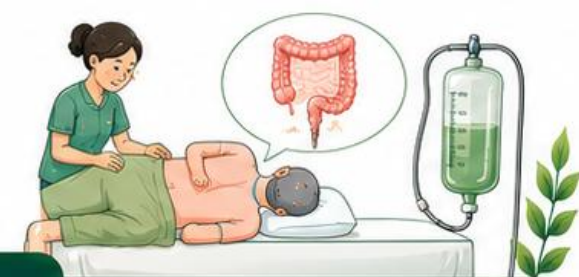


ปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการ
ท้องผูกเรื้อรัง



2.3 การสวนอุจจาระผู้ป่วย

การสวนอุจจาระ หรือการสวนทวารหนัก (enema) หมายถึง การใส่สารละลายหรือน้ำยาเข้าไปในลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง โดยผ่านทางทวารหนัก เพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้ขับถ่ายออก หรือเพื่อให้ยาหรือสารอื่นที่ใช้ในการรักษาไว้ในลำไส้



2.3.1 หลักในการสวนอุจจาระ

1 ชนิดของสารน้ำที่เหมาะสมกับการสวนอุจจาระ

ควรพิจารณาจากอายุ สภาพของร่างกาย พยาธิสภาพของโรค และวัตถุประสงค์ในการสวนอุจจาระ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสวนอุจจาระ



2 ระยะเวลาและปริมาณสารน้ำที่ใช้ในการสวนอุจจาระ

นอกจากจะเป็นไปตามหลักวิชาการแล้ว ควรคำนึงถึงข้อจำกัดของผู้ป่วยแต่ละบุคคลด้วย



3 ไม่ทำการสวนอุจจาระในผู้ป่วยต่อไปนี้



มีอาการลำไส้อุดตัน
(bowel obstruction)



มีการอักเสบของลำไส้
เช่น ลำไส้ติ่งอักเสบ
(appendicitis)



มีการติดเชื้อ
ในช่องท้อง
(infection of abdomen)



ผู้ป่วยภายหลัง
ผ่าตัดลำไส้
(post rectal surgery)



หมายเหตุ

ก่อนการสวนอุจจาระทุกครั้ง ควรอธิบายขั้นตอนและวัตถุประสงค์ ให้ผู้ป่วยทราบ ตรวจสอบคำสั่งแพทย์ และคำนึงถึงความปลอดภัยและความสบายของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

2.3.2 วัตถุประสงค์ในการสวนอุจจาระ

วัตถุประสงค์ในการสวนอุจจาระขึ้นอยู่กับชนิดของการสวนอุจจาระ (types of enema) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1 เพื่อการสวนล้าง (cleansing enema or enema to be expelled)

คือ การกระตุ้นลำไส้ใหญ่ (colon) และไส้ตรง (rectum) ให้เกิดการระคายเคือง ลำไส้โป่งตึง และมีการเคลื่อนไหวด้วยน้ำหรือน้ำยาที่สวนเข้าไป จนกระทั่งสามารถขับถ่ายอุจจาระออกมาได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ



1.1 บรรเทาอาการท้องผูก
(constipation)
อุจจาระอัดแน่น
(fecal impaction)



1.2 ทำให้ลำไส้ใหญ่สะอาด (cleansing)
เพื่อเตรียมผ่าตัดในการจับความรูสึก
การเตรียมตรวจพิเศษและการเอกซเรย์ (X-ray)
บางอย่าง ในการวินิจฉัยและรักษาโรค
รวมทั้งการเตรียมคลอด เพราะขณะคลอด
หัวเด็กอาจทำให้เกิดแรงดันและ
มีอุจจาระออกมาด้วย



1.3 ช่วยให้การขับถ่าย
อุจจาระเป็นปกติ
ในช่วงที่เข้าโปรแกรม
ฝึกการขับถ่าย



1.4 ช่วยในการขับลม
(carminative enema)
รวมทั้งการขับพยาธิ
(anthelmintic enema)
ในรายที่มีพยาธิหรือ
ปรสิตในลำไส้ใหญ่



2 เพื่อการสวนเก็บ (retention enema or enema to be retained)

คือการสวนน้ำยาบางอย่างเข้าไปเก็บไว้ในลำไส้ใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ



2.1 ทำให้อุจจาระเกิดการอ่อนตัว กระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่มีการบีบตัวดีขึ้น
ซึ่งจะเป็นการสวนเก็บด้วยน้ำมัน (oil-retention enema)



2.2 ให้น้ำทางทวารหนัก (medicated enema) ใช้ในการรักษาและวินิจฉัยโรค
เช่น การสวนยา Neomycin ก่อนผ่าตัดเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ เพื่อลดเชื้อแบคทีเรีย
และการสวนตรวจเอกซเรย์ด้วยแบเรียม (barium enema) ซึ่งจะช่วยให้มองเห็น
ลักษณะ ขนาด และสิ่งผิดปกติของลำไส้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น



แนวทางการพยาบาล เพื่อความปลอดภัย



ตรวจสอบคำสั่งแพทย์
และประเมินผู้ป่วย
ก่อนทำทุกครั้ง



อธิบายขั้นตอน
และวัตถุประสงค์
ให้ผู้ป่วยทราบ



เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
และสะอาดปลอดภัย



ควบคุมอุณหภูมิของสารน้ำ
ให้เหมาะสม (โดยทั่วไป
37-40°C)



ให้ความเป็นส่วนตัว
และช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างนุ่มนวล



สังเกตอาการผิดปกติ
และบันทึกผลการพยาบาล
ทุกครั้ง



2.3.3 สารละลายที่ใช้ในการสวนอุจจาระ

ปัจจุบันมีการใช้สารละลายเพื่อเป็นน้ำยาในการสวนอุจจาระหลายชนิด ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มของน้ำยาตามความเข้มข้นของสารละลายได้ 4 กลุ่ม



1 สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับ ความเข้มข้นของเลือดในร่างกาย (isotonic solution)

ตัวอย่าง : 0.9% N.S.S.



- ปลอดภัยมากที่สุด นิยมใช้ในการสวนล้างที่ใช้ปริมาณน้ำมาก และสวนในผู้ป่วยที่ไม่ต้องการให้ลำไส้ได้รับการระคายเคืองด้วยน้ำสบู่
- ช่วยแก้ปัญหการเสียสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย (electrolyte imbalance)
- ควรระมัดระวังการใช้ในเด็ก อาจทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลของน้ำและเกลือแร่จากความเข้มข้นของเกลือที่ได้รับ

เหมาะสำหรับ : ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยที่ต้องการสวนล้างปริมาณมาก และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสารน้ำและเกลือแร่ไม่สมดุล

2 สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า ความเข้มข้นของเลือดในร่างกาย (hypotonic solution)

ตัวอย่าง : น้ำสะอาด หรือน้ำประปา



- ใช้สวนในรายที่มีโรคของลำไส้ใหญ่ และเตรียมตรวจภาพทางรังสี หรือผ่าตัดบริเวณลำไส้ใหญ่
- ไม่ทำการสวนด้วยน้ำซ้ำเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องกัน
- น้ำจะซึมผ่าน (osmosis) เข้าสู่เซลล์ อาจทำให้เกิดการเสียสมดุลของเกลือแร่ หรือน้ำในร่างกายมากเกินไป จนเกิดภาวะ "น้ำเป็นพิษ" (water intoxication)
- ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารน้ำและเกลือแร่ เช่น โรคหัวใจ โรคไต และผู้ป่วยเด็ก

เหมาะสำหรับ : ผู้ป่วยเตรียมตรวจ/ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ที่ไม่มีปัญหาสารน้ำและเกลือแร่

3 สารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่า ความเข้มข้นของเลือดในร่างกาย (hypertonic solution)

ตัวอย่าง : sodium phosphate



- มักบรรจุในน้ำยาสวนสำเร็จรูป เช่น Fleet enema®, Unison enema®, Patar enema®, Royal-C enema®
- มีส่วนประกอบสำคัญคือ sodium diphosphate และ sodium phosphate
- ใช้ในปริมาณน้อย ลดความอ่อนล้าและความกลัวจากการสวนปริมาณมาก
- ดึงน้ำออกจากผนังลำไส้ (osmosis) ทำให้อุจจาระอ่อนตัว กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้

ไม่ควรใช้ใน : ผู้ป่วยขาดน้ำ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยจำกัดเกลือ และผู้ป่วยเด็ก

4 การสวนด้วยน้ำสบู่ (soap solution enema หรือ soapsuds enema เขียนย่อว่า S.S.E)

ตัวอย่าง : น้ำสบู่ 3-5 มล. + น้ำ 1,000 มล.



- น้ำสบู่ช่วยกระตุ้นให้เยื่อลำไส้ระคายเคือง ลำไส้ใหญ่โป่งตึงและบีบตัวได้ง่ายขึ้น
- อัตราส่วนที่เหมาะสม : น้ำสบู่ 3-5 มล. กับน้ำ 1,000 มล. ควรมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขาว
- ไม่ควรผสมเข้มข้นกว่านี้ เพราะอาจทำให้ผนังลำไส้ระคายเคือง และเกิดลำไส้อักเสบ (colitis)
- การเตรียม : หั่นสบู่แข็งฝอย เติมน้ำเดียวพอจนกลายเป็นน้ำสบู่เข้มข้น

เหมาะสำหรับ : ใช้สวนล้างทั่วไป กระตุ้นการขับถ่าย

ก่อนทำการสวนอุจจาระทุกครั้ง พยาบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงชนิดและปริมาณของสารละลายที่ใช้ในการสวนอุจจาระ ระยะเวลาที่เกิดผล ผลที่เกิดขึ้น ผลข้างเคียง รวมทั้งการจัดท่าอนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด

ชนิดสารละลาย (ตัวอย่าง)	ปริมาณ (มล.)	ระยะเวลา (นาที)	ผลที่เกิด	ผลข้างเคียง
1 isotonic (0.9% NSS)	500-1,000	15-20	ลำไส้ใหญ่โป่งตึง กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ ทำให้อุจจาระอ่อนตัว	อาจมีการคั่งของโซเดียม (Na)
2 hypotonic (น้ำประปา)	500-1,000	15-20	ลำไส้ใหญ่โป่งตึง กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ ทำให้อุจจาระอ่อนตัว	ความไม่สมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ (electrolyte) เกิดภาวะน้ำเป็นพิษ
3 hypertonic (sodium phosphate)	90-120	5-10	ดูดน้ำเข้ามาในลำไส้ใหญ่	มีการคั่งของโซเดียม (Na)
4 soapsuds (น้ำสบู่ 3-5 ml. + น้ำ 1,000 ml.)	500-1,000	10-15	ระคายเคืองเยื่อลำไส้ ทำให้ลำไส้ใหญ่โป่งตึง	ระคายเคืองเยื่อลำไส้

ท่าอนที่เหมาะสมในการสวนอุจจาระ

ผู้ใหญ่



ท่าอนตะแคงซ้าย (Sim's position) เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไป



ท่าอนหงายชันเข่า (dorsal recumbent position) ใช้ในผู้ป่วยที่นอนเตียง หรือต้องการความสะดวก

เด็กเล็ก / เด็กโต และผู้สูงอายุ



- จัดให้นอนหงายชันเข่า (dorsal recumbent position) บนหมอนอ่อน
- เด็กเล็ก : กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักยังไม่แข็งแรง
- ผู้สูงอายุ : กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักอ่อนสมรรถภาพ กลั้นอุจจาระไม่ได้เต็มที่



การสวนอุจจาระ : อุณหภูมิที่เหมาะสม

การใช้ในเด็กและผู้ใหญ่ และปริมาณน้ำยาที่ใช้



อุณหภูมิของน้ำยาที่เหมาะสม

อุณหภูมิของน้ำยาที่อุ่นปานกลางและเหมาะสมกับวัยจะช่วยใหกล้ามเนื้อบริเวณลำไส้คลายตัว
น้ำยาร้อนเกินไป อาจทำอันตรายต่อเยื่อลำไส้ • น้ำยาเย็นเกินไป อาจทำให้ปวดเกร็งท้องหรือเป็นตะคริว (abdominal cramping) ได้

วัยเด็ก



อุณหภูมิที่เหมาะสม
37.7 °C
(100 °F)



วัยผู้ใหญ่



อุณหภูมิที่เหมาะสม
40-43 °C
(105-110 °F)



ความลึกในการสอดท่อสอดทวารหนัก (Rectal Tube)



เด็กเล็ก
สอดลึก
1-1.5 นิ้ว



เด็กโต
สอดลึก
2-3 นิ้ว



ผู้ใหญ่
สอดลึก
3-4 นิ้ว



ปริมาณน้ำยาที่ใช้ในการสวนอุจจาระ (แตกต่างกันตามช่วงวัย)

ช่วงวัย (อายุ)	ปริมาณน้ำยาที่ใช้ (มล.)
 เด็กอ่อน (infant) (1 เดือน - 1 ปี)	150 – 250 มล.
 เด็กเล็ก (toddler) (1-3 ปี)	250 – 350 มล.
 เด็กวัยเรียน (child) (6-12 ปี)	300 – 500 มล.
 วัยรุ่น (adolescent) (12-18 ปี)	500 – 700 มล.
 ผู้ใหญ่ (adult)	750 – 1000 มล.



น้ำยากลุ่มความเข้มข้นมาก (hypertonic solution) ไม่จำเป็นต้องอุ่น สามารถใช้น้ำยาได้ในอุณหภูมิห้อง

ข้อควรคำนึงในการสวนอุจจาระในเด็ก



ปัจจุบันนิยมใช้น้ำเกลือ (0.9% NSS)



ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง (hypertonic solution) อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตหรือมีภาวะน้ำเป็นพิษได้



ควรใช้ท่อสอดทวารหนัก (rectal tube) แทนหัวสวน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเยื่อลำไส้



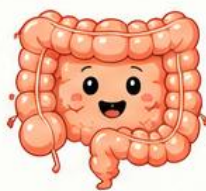
อ้างอิง: Potter, et al., 2011: 1016



จุดมุ่งหมาย

เลือกชนิดและปริมาณน้ำยาให้เหมาะสมกับวัย สภาพผู้ป่วย เพื่อผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด





2.3.4 อุปกรณ์ในการสวนอุจจาระ



1) ถาดสี่เหลี่ยมบรรจุ



1.1 ชุดหม้อสวน (enema can) ประกอบด้วย

- สารละลายตามแผนการรักษาใส่ในหม้อสวน
- หัวสวน (enema stopcock) หรือสายสวน (rectal tube)



หัวสวน (enema stopcock)



สายสวน (rectal tube)

1.2 ซามรูปโตบรรจุผ้าก๊อช (gauze) ขนาด 3x3 นิ้ว จำนวน 1-2 ผืน และกระดาษชำระ (toilet tissue)



1.3 สารหล่อลื่น เช่น วาสลีน (vaseline) เค-วาย เจลลี่ (K-Y jelly) เป็นต้น



1.4 ถุงมือใช้ครั้งเดียว (disposable) จำนวน 1 คู่



2 ผ้าคลุมตัว 1 ผืน



3 เสาควนหม้อสวน (stand)



4 หม้อออนพร้อมที่ปิด



5 ชุดชำระทำความสะอาด



หมายเหตุ



เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน
ตรวจสอบความพร้อมก่อน
การสวนอุจจาระทุกครั้ง



เลือกใช้น้ำยาและอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับวัยและ
สภาพผู้ป่วย



อธิบายขั้นตอน
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจ
และให้ความร่วมมือ



เน้นความปลอดภัย
ลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่ม
ความสบายของผู้ป่วย



2.3.5 ขั้นตอนการปฏิบัติการสวนอุจจาระ (Enema Procedure)

การประเมิน วางแผน และเตรียมผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อให้การสวนอุจจาระมีประสิทธิภาพและปลอดภัย



1 การประเมิน (Assessment)



สิ่งที่ต้องประเมินก่อนสวนอุจจาระ

- 1 ตรวจสอบคำสั่งการรักษาและ
วัตถุประสงค์ของการสวน
- 2 ยืนยันตัวผู้ป่วยและประเมิน
ความสามารถในการขับถ่าย
- 3 ประเมินการขับถ่ายครั้งสุดท้าย
และฟังเสียงลำไส้
- 4 ประเมินริดสีดวงทวารและ
อาการปวดท้อง
- 5 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และ
ความวิตกกังวลของผู้ป่วย



เป้าหมาย

วางแผนการสวนอุจจาระได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย

2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis)



ตัวอย่าง Nursing Diagnosis



ไม่สุขสบาย แน่นท้อง อึดอัด
เนื่องจากมีอุจจาระคั่ง
ในลำไส้ใหญ่



แบบแผนการกำจัดวัช
ระจําวันเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากไม่สามารถขับถ่าย
อุจจาระได้

3 การวางแผน (Planning)



ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ✓ ไม่มีอุจจาระคั่งในลำไส้ใหญ่
- ✓ อาการแน่นท้อง อึดอัดลดลง
- ✓ ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบายมากขึ้น
- ✓ ผู้ป่วยเข้าใจเหตุผล ขั้นตอน
และภาวะแทรกซ้อน
- ✓ มีความร่วมมือในการทำหัตถการ
- ✓ เตรียมอุปกรณ์และน้ำยาครบถ้วน



4 การเตรียมน้ำยาสวนอุจจาระ

อุณหภูมิที่เหมาะสม



ผู้ใหญ่



40.5 – 43°C
(105 – 110 °F)



เด็ก

37.7°C
(100 °F)

เหตุผลสำคัญ



ร้อนเกินไป

→ ทำลายเยื่อบุลำไส้



เย็นเกินไป

→ ปวดเกร็งท้องและเกิดตะคริว



อุณหภูมิที่เหมาะสม

→ ช่วยให้ลำไส้คลายตัว

→ สวนอุจจาระได้ผลดี

→ ลดภาวะแทรกซ้อน



หลักสำคัญของการสวนอุจจาระ



ประเมินผู้ป่วย
ก่อนทุกครั้ง



อธิบายขั้นตอน
เพื่อลดความกังวล



เตรียมน้ำยา
และอุปกรณ์ให้พร้อม



ใช้อุณหภูมิ น้ำยา
ที่เหมาะสม



ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
และส่งเสริมสุขสบาย
ของผู้ป่วย



2.3.5 ขั้นตอนการปฏิบัติการสวนอุจจาระ (Enema Procedure)

การประเมิน วางแผน และเตรียมผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อให้การสวนอุจจาระมีประสิทธิภาพและปลอดภัย



1 การประเมิน (Assessment)



- 1 ตรวจสอบคำสั่งการรักษา และวัตถุประสงค์ของการสวน
- 2 ยืนยันตัวผู้ป่วยและประเมินความสามารถในการขับถ่าย
- 3 ประเมินการขับถ่ายครั้งสุดท้าย และฟังเสียงลำไส้
- 4 ประเมินริดสีดวงทวาร และอาการปวดท้อง
- 5 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความวิตกกังวลของผู้ป่วย



เป้าหมาย

วางแผนการสวนอุจจาระได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis)

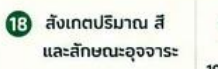
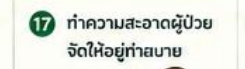
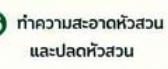
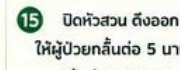
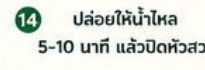
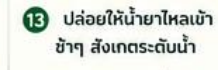
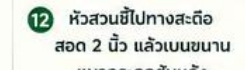
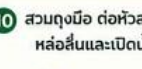
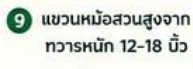
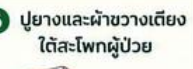
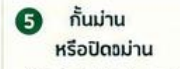
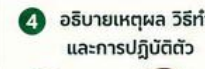
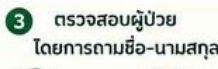
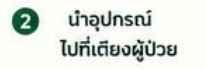


◆ ไม่สุขสบาย แน่นท้อง อึดอัด เนื่องจากมีอุจจาระค้างในลำไส้ใหญ่



◆ แบบแผนการกิจวัตรประจำวัน เปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระได้

3 การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation)



หลักสำคัญของการสวนอุจจาระ



ประเมินผู้ป่วย ก่อนทุกครั้ง



อธิบายขั้นตอน เพื่อลดความกังวล



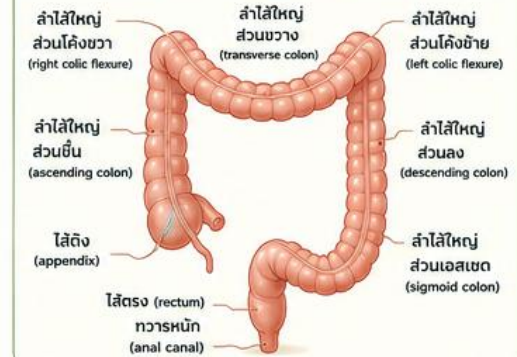
เตรียมน้ำยาและอุปกรณ์ให้พร้อม



ใช้อุณหภูมิ น้ำยา ที่เหมาะสม

ความรู้พื้นฐาน

โครงสร้างลำไส้ใหญ่ (Colon)



ท่าผู้ป่วยในการสวนอุจจาระ

1. ทำนอนตะแคงซ้าย ก้มขวา (Sim's position)



2. ทำนอนหงายชันเข่า (dorsal recumbent position)



5 การประเมินผล (Evaluation)

- 1 ไม่มีอาการเกร็งหน้าท้องขณะสวน อุจจาระถูกขับออกจำนวนมาก
- 2 ไม่มีอาการแน่นอึดอัดท้อง อาการปวดเกร็งหน้าท้อง



6 การบันทึกและรายงาน (Documentation)

- 1 จำนวนและชนิดของน้ำยาที่ใช้
- 2 เวลาที่ใช้ในการสวนอุจจาระ
- 3 ประสิทธิภาพของการขับถ่ายภายหลังสวน
 - อาการและปัญหาที่เกิดขึ้นขณะสวน
 - ปริมาณและลักษณะของอุจจาระ
 - ปัญหาและสภาพผู้ป่วยภายหลังสวน





ขอบคุณ

♥ ทุกคนที่ตั้งใจฟัง ♥

ขอให้ทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้
ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย



THANK
YOU